

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
INSTITUTO DE PSICOLOGIA
Programa de Pós-Graduação em Psicanálise – Clínica e Cultura

INGRID EDUARDA RIOS ESTRADA

Linguagem, corpo e psicossomática na experiência analítica

Porto Alegre, RS
2026

INGRID EDUARDA RIOS ESTRADA

Linguagem, corpo e psicossomática na experiência analítica

Dissertação apresentada como parte dos requisitos para
obtenção do título de Mestre em Psicanálise no Programa
de Pós-Graduação em Psicanálise: Clínica e Cultura da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Orientador: Prof. Dr. Fernando Hartmann

Porto Alegre, RS

2026

INGRID EDUARDA RIOS ESTRADA

Linguagem, corpo e psicossomática na experiência analítica

Dissertação apresentada como parte dos requisitos para obtenção do título de Mestre em Psicanálise no Programa de Pós-Graduação em Psicanálise: Clínica e Cultura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Orientador: Prof. Dr. Fernando Hartmann

BANCA EXAMINADORA

Prof^a. Dra. Marta Regina de Leão D'Agord - Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Prof^a. Dra. Ana Lúcia Mandelli de Marsillac - Universidade de Santa Catarina

Prof^a. Dra. Cristiane de Oliveira Santos - Universidade Federal da Bahia

Porto Alegre, RS

2026

Este trabalho é dedicado aos meus pais, Eduardo e Janete, que com amor, esforço e presença constante sustentaram meus caminhos mesmo nos momentos mais difíceis.

Este percurso também é de vocês.

AGRADECIMENTOS

Agradeço, primeiramente, ao meu orientador, Fernando Hartmann, pela disponibilidade, paciência e contribuições ao longo deste percurso, que foram essenciais para o desenvolvimento deste trabalho e para minha formação acadêmica.

À instituição UFRGS e ao PPG de Psicanálise: Clínica e Cultura, pelo espaço de formação, pelas oportunidades de aprendizado e pelo suporte ao longo desta pesquisa.

À Ana Lúcia Marsillac e Marta D'Agord, pelos apontamentos durante a qualificação.

À Cristiane de Oliveira Santos, Ana Lúcia Marsillac e Marta D'Agord, por gentilmente aceitarem o convite para participar da banca de defesa.

Aos meus pais, Janete e Eduardo, pelo apoio constante e por acreditarem em mim mesmo nos momentos de incerteza. Tudo que foi construído até aqui carrega a marca do cuidado e da confiança de vocês.

Agradeço à minha namorada, Pauline Scott, pelo afeto, paciência e presença nos dias mais difíceis, pelo incentivo nos momentos de cansaço e por caminhar ao meu lado com compreensão e amor.

Aos meus colegas, pelas trocas ao longo dessa trajetória. O percurso foi mais leve e significativo graças às experiências compartilhadas.

A todos que, direta ou indiretamente, contribuíram para a realização deste trabalho, meu sincero agradecimento.

*“Meu corpo, não meu agente,
meu envelope selado,
meu revólver de assustar,
tornou-se meu carcereiro,
me sabe mais que me sei.”*

Carlos Drummond de Andrade

RESUMO

A pesquisa analisou a relação entre linguagem e corpo, a partir do estudo dos fenômenos psicossomáticos, buscando a articulação de significantes percebidos pelo corpo. Sendo o significante aquilo que representa o sujeito para outro significante, o objetivo foi analisar como determinadas afecções corporais são vistas como efeitos da incidência significativa, principalmente quando opera de maneira holofrástica. O método utilizado consistiu na análise da teoria lacaniana sobre corpo e linguagem, vinculando a vinhetas clínicas para pensar os fenômenos psicossomáticos. Portanto, seguindo a ideia de Lacan, o corpo aqui é visto como efeito de linguagem, ao receber uma marca o eleva à condição de significante. É preciso que possua algo no significante que ressoe, esse ressoar nos diz que a pulsão no corpo ecoa. Sendo assim, os resultados encontrados apontam que nestes fenômenos, o corpo é afetado por significantes que não se articulam na cadeia significativa, ficam fixados e incidem diretamente no mesmo. A partir do entendimento da afecção psicossomática como resultado da incidência no corpo por significantes em forma de holófrase, sustenta-se que uma das possibilidades de direção de tratamento nestes casos seria restabelecer o movimento dos significantes fixados na holófrase em direção à produção de metáforas, deslizando na cadeia significativa a partir da falta que constitui o desejo. Considera-se que a reintrodução do desejo, da falta e da ambiguidade na cadeia significativa restabelece a circulação dos significantes fixados.

Palavras-chave: Corpo, Psicossomática, Psicanálise.

ABSTRACT

The study analyzed the relationship between language and the body through the investigation of psychosomatic phenomena, aiming to articulate the signifiers perceived through the body. Considering that the signifier represents the subject for another signifier, the objective was to examine how certain bodily affections may be understood as effects of the incidence of signifiers, particularly when they operate in a holophrastic manner. The method consisted of an analysis of the theoretical contributions of Jacques Lacan concerning the body and language, articulated with clinical examples in order to reflect upon psychosomatic phenomena. From this perspective, the body is conceived as an effect of language, insofar as the mark it receives elevates it to the status of a signifier. For such an inscription to occur, something within the signifier must resonate; this resonance indicates that the drive echoes in the body. The findings suggest that, in these phenomena, the body is affected by signifiers that do not become articulated within the signifying chain; instead, they remain fixed and act directly upon the body. Based on the understanding of psychosomatic affliction as the result of the incidence of signifiers upon the body in the form of a holophrase, it is argued that one possible direction of treatment in such cases would be to reestablish the movement of these fixed signifiers toward the production of metaphors, allowing them to slide within the signifying chain from the lack that constitutes desire. The reintroduction of desire, lack, and ambiguity into the signifying chain is thus considered fundamental for restoring the circulation of these fixed signifiers.

Keywords: Body, Psychosomatic. Psychoanalysis.

Lista de Figuras

Figura 1 - Os quatro discursos de Lacan	37
Figura 2 - As posições	37

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO.....	10
Entre o somático e o psíquico: o enigma da pulsão	24
Estádio do Espelho e a Construção do Eu Corporal	27
Relação entre Corpo e Linguagem, a teoria de Jacqueline Authier-Revuz	32
Sintoma e Fenômeno Psicossomático: Diferenças e semelhança	34
Análise de vinhetas clínicas e formas de intervenção na clínica com FPS.....	44
Recortes de um caso de Psoríase	47
Recortes de um caso de Rosácea	49
Recortes de um caso de Retocolite Ulcerativa	52
Resultados	56
Por fim	64
REFERÊNCIAS	66

INTRODUÇÃO

O sofrimento psíquico pode se expressar através do corpo, evidenciando os efeitos da linguagem que atravessam o sujeito. Diante do que a afeta, cada pessoa vai responder de forma particular, podendo manifestar sintomas corporais como modo de inscrição do mal-estar vivido.

O termo “psicossomática” surgiu através do alemão Heinroth (1773-1843), professor de psiquiatria, como uma extensão médica, ao fazer referência à insônia, bem como às influências das paixões na tuberculose. Ele lançou então, a expressão psicossomática e mais tarde o termo somato-psíquico, no qual abordava a influência dos fatores orgânicos nos emocionais (MENDONÇA, 2006). Tempos depois, com suas descobertas sobre a histeria, Freud contribuiu para uma melhor compreensão dos fenômenos psicossomáticos. Nos primeiros estudos psicanalíticos as somatizações tinham uma acepção simbólica, parecidos com sintomas neuróticos (COSTA; ALVAREZ, 2015). Freud fez estudos, junto com Charcot e posteriormente com Breuer, sobre a histeria de conversão, com o objetivo de comprovar que as manifestações corporais da histeria de conversão tinham origem psicológica. Estes estudos foram o principal caminho de ligação entre a Psicanálise e a Psicossomática, pois possibilitaram a comprovação de que mente e corpo atuam juntos na origem de uma doença (SIMÃO; MOREIRA, 2010).

Breuer e Freud (1893/1895), abordam os sintomas histéricos como decorrente de uma “soma de excitação” que chega ao sistema nervoso, sendo transformada em sintoma permanente. Esta soma de excitação seria causada por um trauma, sendo convertida em sintomas somáticos, por esse motivo houve dificuldade no reconhecimento da doença como distúrbio psíquico. O termo “conversão”, característico da histeria, diz respeito à transformação de excitação psíquica em sintomas corporais. Os autores também evidenciaram que certos sintomas, sendo eles motores ou sensitivos, dizem respeito à representação psíquica de perturbações ligadas a processos como sedução, hipersexualidade ou inibição. Estes termos possibilitaram a compreensão do psicossomático, do significado dos sintomas e o que ocorre com os pacientes somáticos (BITELMAN, 1997).

Após Freud, em meados do século XX, os estudos sobre a psicossomática avançaram com Franz Alexander e a Escola de Psicossomática de Chicago, com suas contribuições pioneiras referentes ao tema, onde desenvolvem uma teoria que procurava estabelecer relações entre as emoções reprimidas e o aparecimento de sintomas físicos (MELLO FILHO, 2010). Para Alexander a histeria seria uma conversão emocional que passa para os órgãos sensitivos e musculatura, estes sintomas não seriam diferentes do funcionamento normal, isto é, do ponto de vista fisiológico os sintomas conversivos da pessoa histérica se assemelha às usuais inervações voluntárias ou expressões, só que na histeria teria origem inconsciente. Alexander constatou ainda que nas doenças, nas quais há alterações nos órgãos, o fator emocional também é considerado importante, pois com o tempo, a estimulação repetitiva pode causar alterações morfológicas. O autor nomeia isto de distúrbio orgânico psicogênico. Ele elaborou também o conceito de constelação psicodinâmica específica, em que ao vivenciar experiências emocionais, algumas reações despertam conflitos internos que fizeram parte do desenvolvimento do sujeito. Com isso ele considera que toda doença possui caráter psicossomático, onde nada é somente físico ou somente psíquico (SILVA, 2016).

A Escola de Chicago pontuou também que apesar dos sintomas histéricos e vegetativos representarem uma tensão emocional crônica que não foi descarregada, os mecanismos atribuídos aos dois não são iguais, nem no aspecto psicodinâmico, tampouco no fisiológico. Para esta escola, a histeria representa a busca de alívio simbólico de um estado tensional, focado no sistema neuromuscular. Já a “neurose orgânica”, Alexander comenta que esta é resultado de um distúrbio psicogênico de um órgão vegetativo, não havendo nenhum significado psicológico. As psiconeuroses seriam então de ordem representativa, isto é, possuem um significado psíquico, já os transtornos psicossomáticos, apesar de serem influenciados pelo psíquico, não possuem significado. Com isso, a Escola de Chicago, constatou que existe uma base psicogenética nas doenças psicossomáticas, ocasionando experiências emocionais não satisfatórias na relação do bebê com a mãe, produzindo frustração e angústia. Portanto, o surgimento de doenças seria a partir da tensão crônica que ocorre na vivência da frustração que altera a atividade fisiológica (COSTA; ALVAREZ, 2015). A escola de Chicago busca, com isso, estabelecer uma relação

entre a personalidade do sujeito com as doenças somáticas por ele apresentadas, dentre elas a úlcera, distúrbios digestivos, asma e enxaquecas (VOLICH, 2000).

No entanto, o Instituto de Psicossomática de Paris, discorda das concepções da Escola de Chicago e ressalta o valor do trauma para a origem das doenças psicossomáticas. Para estes o trauma é proveniente de uma excitação intensa, na qual a organização psicossomática não foi capaz de lidar, pela quantidade de desordens que o estímulo determinou e não pelo evento do trauma em si (COSTA; ALVAREZ, 2015). Este instituto desenvolve teorias em busca da compreensão da relação entre o aparelho psíquico e como este estabelece a função de regular os sintomas somáticos, além de procurar entender o destino das excitações do organismo. Particularidades do desenvolvimento do sujeito e as circunstâncias de vida podem influenciar no aparecimento de manifestações somáticas ou psíquicas, tanto patológicas quanto normais. Autores como Parcheminey e Ziwar, contestam que as doenças psicossomáticas decorram das ideias de conversão e psicogênese. Estes autores consideram as doenças psicossomáticas dentro da evolução genética e colocam como inseparável o desenvolvimento biológico e o psicológico. Acredita-se que não é necessária uma visão psicogenética para pressupor que os fatores psicodinâmicos sejam parte da etiologia da doença (VOLICH, 2000).

Volich (2000) discorre que a relação entre o psíquico e o somático é definida nas relações primitivas, em que ocorre a passagem do corpo para psique, quando o bebê tenta suportar a frustração, a dor física e o sentimento de vazio. Este momento é mediado pela psique materna, dando uma representação ao estado do bebê que pode ou não corresponder ao que a criança está sentindo. Sendo assim, a primeira experiência de representação é ligada ao corpo e sua atividade sensorial. A mãe oferece, além de satisfação das necessidades básicas instintivas, uma proteção na forma de pára excitações, possibilitando a percepção e a interpretação dos movimentos corporais e falas do bebê. Pode-se perceber que a relação do bebê com outro ser humano é essencial para a formação do aparelho psíquico. Quando há conturbações nessas relações, especialmente na fase inicial da vida, oportuniza uma fragilidade do funcionamento psicossomático.

Cabe citar também que os sintomas psicossomáticos estão mais próximos das neuroses atuais do que da histeria. Na histeria é criado um corpo fantasma controlado pela

psique para representar seus traumas, enquanto nas doenças somáticas o corpo realmente desenvolve uma doença, não é algo representado. Este pensamento dispensa qualquer representação, pois ele é literal. Portanto, se torna imprescindível conhecer os sintomas dentro de uma visão genética e evolutiva (VOLICH, 2000).

Ainda, as neuroses atuais têm configuração diferente das psiconeuroses em sua etiologia e dinâmica psíquica. O conceito de neurose atual foi deixado de lado nos estudos de Freud, sendo um caso à parte da psicanálise. Entretanto, muitas questões apresentadas por ele, podem ser associadas com o que se entende como campo da psicossomática. O termo *neurose atual* foi citado por Freud pela primeira vez em 1898. Ele sustentou a ideia de que a principal causa das neuroses é de origem sexual, sendo esta a base das estruturas psicanalíticas, mas atenta para o fato de que o papel exercido pela sexualidade era diferente em cada caso. Sendo assim, separou as neuroses em dois grupos: neuroses atuais e psiconeurose de defesa, deixando claro que os sintomas dos dois poderiam aparecer juntos em alguns casos. Nas neuroses de defesa, estão neurastenia e a neurose de angústia, nestas é possível chegar ao agente sexual que origina as doenças logo na anamnese, ou seja, no primeiro encontro, por ser parte da vida sexual atual. Nas psiconeuroses, apesar de haver um fator ligado à vida sexual do paciente, esta ligação não seria reconhecida por ele. As neuroses atuais teriam sua etiologia no momento atual, e as psiconeuroses, na infância (FERRAZ, 1998).

Percebe-se que há algumas concepções sobre o conceito de psicossomática. Neste estudo trago à luz os efeitos da linguagem sobre o corpo. Desde Freud, a psicanálise estuda o inconsciente e seu impacto no processo de subjetivação, sendo o sujeito efeito e, ao mesmo tempo, produtor de discursos. Nesta perspectiva, interessa analisar de que modo a linguagem incide no corpo e pode ter impacto nas formas de adoecimento. Como Lacan (1957/1998) formulou, o inconsciente é estruturado como uma linguagem, sendo assim, o sofrimento se inscreve nos modos pelos quais o sujeito é atravessado por significantes, não podendo ser reduzido apenas ao biológico. Significante é aquilo que representa o sujeito para outro significante (Lacan, 1964/2008). No campo do fenômeno psicossomático, trata-se aqui de investigar como o corpo é afetado e constituído pela linguagem e torna-se palco de manifestações dos impasses subjetivos.

O inconsciente estruturado como linguagem é muitas coisas, menos exato. E é nesse ponto que a psicanálise intervém, no equívoco e nas incertezas. Partindo dessa ideia, este estudo buscou analisar o adoecimento ou fenômeno psicossomático, como é mais conhecido nos trabalhos encontrados pelo viés psicanalítico. O fenômeno psicossomático é visto como um desafio para os campos da medicina, psiquiatria e psicologia, por não ser puramente biológico e tampouco puramente psicológico (Birman, 2003). Ele convoca uma escuta que ultrapasse a cisão entre corpo e mente, exigindo uma abordagem que considere a complexidade do sujeito em sua relação com a linguagem, o inconsciente e o corpo. Nesse contexto, seria justo pensar em univocidade no sujeito? Reduzi-lo a uma única dimensão, seja orgânica ou psíquica, pode levar ao apagamento de sentidos que se inscrevem no corpo como manifestações de um sofrimento que não encontra palavras. Sobre isso, Lacan (1964/2008) já dizia que referir o sujeito em relação à realidade que é suposta e não em relação ao significante é o que implica a degradação na constituição do sujeito enquanto efeito da linguagem.

O presente estudo aborda a temática do corpo, mais especificamente os adoecimentos psicossomáticos e as repercussões ligadas a esse fenômeno. O que chama a atenção, é o encaminhamento de pacientes para a análise quando o serviço médico não consegue dar conta de demandas físicas; o corpo insiste em inscrever algo do inconsciente que não encontra lugar para elaboração psíquica. O adoecimento físico tende a ocupar um lugar de maior legitimidade quando comparado ao sofrimento psíquico. O corpo doente é frequentemente validado por exames e diagnósticos, desta forma encontra maior acolhimento no laço social. Já o sofrimento psíquico, por ser uma dimensão menos tangível e atravessada pela linguagem e inconsciente, tende a ser silenciado e até mesmo estigmatizado. Sendo assim, o sintoma corporal pode operar como um caminho de expressão mais “aceitável” do mal-estar. Portanto, o trabalho da psicanálise é oferecer um espaço de escuta para que outros discursos possam circular.

Paraboni (2019) ressalta que a subjetividade humana é constituída desde o início na relação com o outro, assim como na experiência corporal. Portanto, buscar compreender a relação do Eu/corpo e também Eu/outro é importante para refletir as singularidades das patologias corporais. A autora afirma que estamos diante de outra esfera corporal, para além do corpo biológico, pois há um corpo erógeno que está

envolvido pela economia pulsional.

Considero a clínica psicanalítica fundamentalmente uma clínica do corpo, seja ela considerada através da angústia, do sintoma, do objeto ou do significante, do sexual ou do discurso, do gozo ou do sentido. O corpo está sempre presente, tudo parte dele, para a ele retornar. Portanto, desconsiderar o corpo na clínica significaria aceitar que o corpo não tem nada a dizer, sendo que a fala parte dele (Askofaré, 2019).

Ao introduzir essa pesquisa, será necessário voltar aos estudos de Freud sobre Histeria, visto que as condições de descoberta e invenção da psicanálise foram a partir dela, colocando o corpo na linha de frente da clínica psicanalítica, enquanto lugar de sintoma. Devo dizer que não pretendo me prender em contextualizar a histeria, mas relembrar alguns aspectos será importante para trazer a compreensão do corpo para além do biológico e também a importância do conceito de *talking cure*. Será que o que foi trabalhado por Freud na histeria, influenciando na compreensão de mente/corpo para a psicanálise, poderia também ser aplicado a analisantes com dores crônicas, com psoríase, reumatismo, artrite ou com retocolite ulcerativa?

Desde a Idade Média, as alterações corpóreas da histeria tomam a cena na cultura. Justificada como ação do diabo, os sintomas histéricos eram relacionados às mulheres pecadoras e feiticeiras, punidas por mal comportamento. No Renascimento, as mulheres histéricas foram colocadas em fogueiras como exemplo para o povo não seguir as atitudes pecaminosas. Em meados do século XVII, a histeria volta a aparecer como uma patologia que copiava outras doenças, mas não obtinha o mesmo diagnóstico. Naquela época, o conhecimento em torno deste sofrimento não dava conta de compreendê-lo, tornando a voltar para a ideia inicial, o útero. Hipócrates (460 a.C.-377 a.C.) acreditava que a histeria se manifestava apenas em mulheres (Catani, 2014).

Citando Catani (2014), é lembrado que, por muito tempo, a histeria ficou associada à mulher sensual com uma vida sexual ativa, no entanto, muitos autores, entre eles Briquet, comprovaram, por meio de observações clínicas, que estas mulheres padeciam principalmente por não se entregarem aos prazeres sexuais. Não se afastava a origem nervosa da histeria, mas associava também uma predisposição genética.

Salpêtrière e Nancy foram escolas importantes para a construção dos estudos sobre histeria. A primeira escola, representada por Charcot, pensava ser possível

identificar um sintoma real e investigá-lo por meio da hipnose. Com Charcot, foi possível comprovar a existência de sintomas histéricos em homens, promovendo a separação do útero e a histeria. Na segunda escola, conduzida por Berhain e Babinski, a histeria foi abordada como um fenômeno cultural, sendo afetada pelo meio. Para eles, a sintomatologia precedia de sugestões, sendo o histérico um simulador consciente do seu comportamento (Catani, 2014).

Freud surge com seus estudos sobre histeria, descrevendo-a como sem definições claras, associada a contraturas, distúrbios sensoriais, convulsões e paralisias. Com isso, deixa de ser vista como simulação. As regiões afetadas apresentavam uma excitabilidade distinta das outras áreas do corpo (Freud, 1886/1987). Oliveira e Winter (2019) abordam a visão freudiana e lacaniana sobre o corpo, visto como pulsional, erógeno e formado a partir do contato consigo mesmo e com o mundo externo, causando assim marcas. Estas marcas são reatualizadas durante a vida, ou seja, a constituição dessas marcas no corpo passa pelos registros do Real, Imaginário e Simbólico.

Freud (1896), ao abordar a histeria, diz que o estado histérico é uma consequência tardia, determinada por experiências traumáticas vividas no passado, formando símbolos mnêmicos. No entanto, durante o tratamento destes casos, mesmo chegando na cena traumática, os sintomas não cessam, induzindo assim, o analista a seguir mais fundo com a busca de outra possível cena traumática, que talvez esteja mascarada pela primeira como uma forma que o sujeito encontrou para ligar a cadeia de associações. Com isso, a combinação da primeira e segunda cena traumática produziria os sintomas histéricos, ou seja, uma das cenas seria a força traumática e a outra o efeito determinante.

Para compreender melhor como funciona a cadeia de associação na histeria, Freud (1896) traz alguns exemplos, entre eles o do vômito histérico, associado à paciente ter comido uma maçã estragada, porém não apenas isso, esta cena recordou outra situação em que ela recolhia frutas no pomar e encontrou um animal morto, causando repulsa. Com esse exemplo, percebe-se que a cadeia de associação possui dois ou mais elos e a cena traumática se ramifica, se interligando com novos significantes. A cada novo acontecimento, a experiência traumática primária vai ficando sobreposta por novas memórias.

Para Freud (1896), a histeria tinha sua origem na experiência sexual, seu

retraimento estaria no centro dos sintomas histéricos. Nestes casos, sempre há um ou mais acontecimentos sexuais prematuros. A experiência sexual infantil é a base da histeria, acontece geralmente até os oito anos de idade e se torna inconsciente. Por vezes, as condições das cenas sexuais infantis adquirem poder de determinar sintomas apenas posteriormente em uma cena relativamente igual ou que remete à anterior.

A histeria foi explicada como uma alteração na representação daquela parte do corpo lesionada, associando-a afetivamente a um acontecimento moral que acaba impedindo seu funcionamento. No processo terapêutico, o trabalho começaria por uma primeira lembrança, que está associada ao sintoma histérico, para depois seguir o caminho de encontro a uma lembrança anterior que estaria mais perto do efeito causado no paciente. Esta primeira lembrança ganha uma condição de símbolo, substituindo a cena principal que ocorreu na infância e que, por falta de maturidade, não teve compreensão, portanto a cena substitutiva estaria carregada de afeto que não foi despertado antes e agora ganha uma conotação sexual devido à puberdade, sendo o motivo para acionar a defesa do eu (Bocca, 2011).

Dunker (2016) apresenta o conceito psicanalítico de “defesa” como forma de lidar com a indeterminação do desejo, da angústia, da pulsão e do trauma. Ao defender-se destas indeterminações, estas se tornam estruturas de ocupação ou determinação, tornando o objeto não apenas determinado, mas determinante. Ao continuar suas descobertas sobre histeria, Freud insere a fantasia como sendo uma realidade psíquica que substitui a cena traumática ou ocupa um lugar ao seu lado. O corpo seria o palco desta fantasia que permite encenar a linguagem do inconsciente através do sintoma (Bocca, 2011).

Pela fala, é permitido que o afeto recalcado encontre uma saída pelo discurso, colocada em uma nova cadeia de associação, assim é possível deslocar da ideia original recalcada, ressignificando o afeto vinculado à lembrança. Então, é por meio da fala que ocorre a oportunidade de se conectar com aquilo que causa sintomas atuais. Supõe-se que o analisante, quando recalca eventos, este passado é constantemente atualizado, muitas vezes por sintomas (Fochesatto, 2011).

Com o caso de Emmy, Freud (1893-1895/2016) percebeu que havia necessidade de deixar a analisante falar livremente. Emmy solicitou que não a interrompesse com

perguntas e a deixasse falar. A fala, portanto, passou a ser um instrumento clínico central. A associação livre permitiu alcançar elementos capazes de liberar afetos, lembranças e conteúdos inconscientes. Com isso, a afirmação freudiana de que o eu não é senhor de sua própria morada (Freud, 1996) permite ir além do conteúdo manifesto de maneira consciente. Assim, as palavras revelam tanto o que o analisante quer falar quanto aquilo que busca ocultar (Fochesatto, 2011).

O processo de transferência que ocorre na análise mostra a possibilidade do inconsciente se deslocar, circular e condensar a figura do analista, tornando-o apto a receber de cada analisante um sentido diferente. O analista, então, seria um representante psíquico que pode ser chamado de suporte significativo (Nasio, 1999, p. 65).

Ao trazer isso para as formas de tratamento dos fenômenos psicossomáticos, considero a enunciação do sujeito como sendo direcionada ao analista extremamente importante para tentar sair da fixidez discursiva dos analisantes, como vamos ver nos casos mais adiante. Algumas vertentes psicanalíticas consideram que exista diferença entre o fenômeno psicossomático e a histeria, segundo Katz e Costa (2021) e Ferraz (1998) a conversão histérica afeta o corpo erógeno e na somatização o corpo afetado é o biológico. Ou seja, a histeria tem valor simbólico em seu sintoma, estaria ligado a fantasia e o fenômeno psicossomático afeta diretamente o órgão, sem simbolização. Sobre isto, vou discorrer a seguir.

Seguindo com a visão de corpo para a psicanálise, ele é visto como uma superfície de inscrição, que ao receber uma marca, através da linguagem, o eleva à condição de significativo, entrelaçando a relação do sujeito consigo mesmo e aos outros. Como dizia Lacan (1970), o corpo pode portar a marca para situá-lo em uma cadeia de significantes, sendo o suporte da relação de gozo, de discurso e também de sintoma.

A amarração do corpo no discurso é o ponto fundamental para buscar compreender o que é corpo, desde sua constituição e estrutura até sua função. É pela incorporação do corpo simbólico que o organismo se corporifica. É questão de pulsão, de gozo (Askofaré, 2019). Isso significa que os sintomas corporais persistem porque cumprem uma função, mantendo algo da estrutura subjetiva em funcionamento. Pensando o corpo como litoral, cabe ao sujeito significar sua existência através do sintoma, da fantasia, dando borda ao

real. A linguagem faz marca, traumatiza o corpo e é na relação de linguagem, corpo e o Outro que o arranjo da vida vai se constituindo, de maneira particular.

Pensando em humanidade, o que se transmite na comunicação não são significados e sim significantes (Hartmann, 2023). O significado está relacionado ao campo do imaginário, ou seja, o significado que damos a uma palavra não é fixo, mas subjetivo e carregado de identificações inconscientes. As palavras podem remeter a fantasias, ilusões e projeções pessoais. O campo imaginário é formado pelas imagens e identificações que estruturam a nossa percepção do mundo e de nós mesmos. Lacan (1957/1998) aponta que o significado, por não ser fixo, está sempre associado a uma cadeia de significantes, pois precisamos de outras palavras para poder explicar um significado. Neste mesmo sentido, compreende-se que pode haver uma “falha” na linguagem, por não abranger tudo, haverá sempre uma falta, uma incapacidade de expressar tudo. Quando nomeiam algo há um motivo por qual ele foi nomeada assim. Ao mesmo tempo que o que foi nomeado acaba por se reduzir a um nome, há algo que se perde.

A lógica do inconsciente segue a mesma linha na rede significante, pois o significante sempre vem antes do sentido, abrindo espaço para interpretações, assim como o inconsciente que nunca entrega o significado pronto, mas sempre sugere, adia ou desloca. O significante é fundamentado pela letra, tornando-o um discurso concreto e possibilitando a inscrição do significante seja pela fala, escrita ou inconsciente (Lacan, 1957/1998). Desta forma, Lacan (1964/2008) afirma que “o inconsciente é estruturado como uma linguagem”.

Lacan (1957/1998), remetendo aos estudos de Freud, vai dizer que o inconsciente nunca aparece de maneira direta, mas por meio de lapsos, atos falhos e sintomas. Sendo assim, o analista não deve apenas atribuir significados fixos, mas escutar os significantes que se articulam entre si, seguindo as regras do inconsciente. Compreendendo que o sintoma tem uma estrutura linguística, possibilita-se trabalhar sua interpretação a partir do

jogo de metáfora¹ e metonímia². Com isso, a psicanálise não trata o sintoma apenas como disfunções a serem eliminadas. Antes de seguir, vou procurar explicar o que é metáfora e metonímia na teoria lacaniana, já que são conceitos fundamentais para analisar o funcionamento do inconsciente e da linguagem em sua estrutura.

Em *A instância da letra no inconsciente ou a razão desde Freud*, seguindo a referência do parágrafo anterior, ao propor que o inconsciente é estruturado como linguagem, é explicado que metáfora e metonímia correspondem aos mecanismos descritos por Freud como condensação e deslocamento. Portanto, a metáfora é um processo onde o significante substitui um outro significante, e a partir disso, cria um novo sentido. Lacan (1999) exemplifica essa operação com a metáfora paterna, onde ocorre a substituição do desejo da mãe pelo significante “Nome-do-Pai”, introduzindo o sujeito na linguagem e instaurando a função simbólica.

A metonímia é definida como o movimento de deslizamento contínuo de um significante para outro, sem uma substituição fixa. É o que expressa a falta e o desejo na linguagem. Assim, o desejo é compreendido como metonímico, pois nunca está plenamente satisfeito, é deslocado de um objeto para outro em busca de algo que o preencha, mas que sempre escapa. Sendo assim, a metonímia é o próprio movimento da cadeia significante e o sentido se constrói na associação e não na substituição (Lacan, 1957/1998). Para concluir a explicação destas operações, pode-se ver que elas demonstram que o sujeito é efeito da linguagem e que se sustenta em um jogo de substituições e deslizamentos de significantes que marcam o inconsciente.

O significante é compreendido como uma marca que pode ser apagada e reescrita, refere-se a um discurso que só ganha sentido em contato com outro significante, é um modo de funcionamento que se enlaça a outros discursos (Hartmann, 2023). Portanto, um sintoma só seria possível de ser elaborado se a partir do relato, esses significantes possam se conectar a outros já existentes.

Lacan (1972/1985) em seu estudo *A Jakobson* explora como o significante se

¹ No dicionário aurélio, metáfora é descrita como figura de linguagem onde há o emprego de outra palavra em sentido diferente do próprio, por analogia ou semelhança, real ou imaginária. Há transferência de significado de uma palavra para outra.

² A metonímia é definida no dicionário como figura de linguagem que se emprega uma palavra que se refere a outro objeto, por possuírem algum tipo de relação. A que se liga por relação de causa e efeito, lugar e produto, todo e parte.

articula na experiência do gozo e como esse gozo está relacionado à substância do corpo. O gozo, para Lacan, não é algo puramente físico ou biológico, é aquilo que se inscreve no sujeito a partir de sua relação com a linguagem. Sendo assim, atravessado pelo simbólico e bordado por significantes. Quando é falado que “o significante é a causa do desejo” (Lacan, 1972, p. 36), quer dizer que a linguagem pode organizar e direcionar o gozo de uma forma em que o sujeito possa experienciá-lo.

O significante tem a função de marcar a divisão do sujeito em relação ao gozo, sem ele não teria como dar borda àquilo que no gozo é uma causa material. O significante impede que essa força libidinal seja em excesso. Intensificado pelo desejo, o gozo é filtrado nos significantes pelos quais o sujeito se relaciona, passa pela linguagem, cultura e significados atribuídos às experiências vividas (Lacan 1972/1985). Sem esse deslize na cadeia significante, o corpo passa a ser fonte ilimitada de gozo.

Para além disso, é preciso compreender que o significante não está diretamente relacionado a uma coisa ou objeto no mundo, mas com um modo de linguagem dentro de um determinado discurso. O discurso é uma forma de laço social que organiza o desejo e a subjetividade. Quem fala não é um humano qualquer, mas alguém que está implicado em um sistema simbólico que o afeta e o estrutura (Lacan, 1973/1985). Sendo assim, o significante não é apenas representação, é algo que afeta o sujeito e sua existência, pois está vinculado ao inconsciente.

Ferreira (2002) nos ajuda a pensar que o sujeito, em Lacan, se funda na falta-a-ser. Isto é, o sujeito não é completo, se constitui na falta estrutural, existe ao entrar na linguagem. Sendo assim, o sujeito não nasce com o corpo, mas precede enquanto efeito do Outro, da linguagem. Já suposto no campo significante, a criança, quando nasce, passa a se alienar, fazendo com que ela se represente no discurso do Outro. Com isso, o desejo do sujeito é visto como desejo do desejo do Outro. O significante passa a ser definido como aquilo que representa (e afeta) um sujeito para outros significantes.

Desde o nascimento, a relação entre o bebê e o Outro — representado, inicialmente, pelo desejo do cuidador — forma a base para a constituição do sintoma. Esse sintoma se estrutura a partir da exclusão de um “resto” de gozo, ou seja, algo que não pôde ser completamente simbolizado e que, por isso, persiste no psiquismo (Ferreira, 2002).

Portanto, desejar está sempre vinculado a um resto não simbolizável. E desejar é diferente do que se experiencia ao realizar um desejo, pois só há algo para desejar quando falta. Quem sustenta esse desejo como ação é a fantasia. Sendo assim, do real como impossível ao significante do desejo, tem um movimento contínuo na cadeia significante, impulsionando o sujeito a continuar construindo novas relações com significantes. Nesse processo há a produção de metáforas e metonímias, mas nunca de forma completa, já que sempre há um vestígio do Real (Ferreira, 2002).

A busca de sentido através da repetição é uma forma de tentar controlar a angústia (Hartmann, 2023). O sintoma pode ser compreendido como uma forma de linguagem, um recorte significativo o qual busca um sentido, produzindo assim uma maneira de gozar. O ganho do sujeito ao se anexar ao gozo está em fantasiar que, de alguma forma, ele pode escapar da angústia estrutural da vida. Podemos pensar em sintomas corporais ou adoecimentos somáticos na ordem do gozo?

Considerando o exposto até aqui, este estudo busca trazer como foco de discussão desdobramentos sobre linguagem, sintoma e corpo, destacando pontos que interessem à abordagem de questões mais específicas dos fenômenos psicossomáticos, pelo olhar da psicanálise. Tendo em vista que o corpo se faz sempre presente na clínica, busca-se analisar como o corpo é atravessado pela linguagem mediante exemplos clínicos que apresentam fenômenos psicossomáticos.

Desconsiderar a complexidade dos sujeitos e ignorar as nuances dos fenômenos psicossomáticos, onde o corpo se torna uma via de expressão do sofrimento emocional, causa a ausência de uma compreensão mais profunda sobre o impacto dos discursos e das vivências pessoais no adoecimento somático, levando à patologização do sujeito e ao silenciamento de sua dor, dificultando a construção de uma narrativa significativa sobre suas experiências.

Além disso, o uso indiscriminado do termo psicossomática para designar afecções que são desprovidas de causa orgânica pode conduzir a diagnósticos equivocados e métodos de tratamento que não encontram consenso entre os profissionais que se deparam com esses casos em sua clínica. Diante desse cenário, é necessário pensar, no campo da psicanálise, uma orientação teórica que possa auxiliar no manejo dos casos que apresentam o chamado fenômeno psicossomático. Vale lembrar que trata-se menos

de estabelecer padrões normativos e sim de sustentar uma posição ética que leve a singularidade de cada sujeito em conta. Já que, quando o sintoma aparece, o sujeito tenta, com seus recursos, responder de uma maneira que possa lidar com a experiência da angústia (Nicolau, 2008).

Portanto, o objetivo desta pesquisa foi usar alguns recortes clínicos para pensar a relação entre corpo e linguagem na psicanálise lacaniana. Analisar de que forma a psicanálise pode contribuir para a análise do corpo tecido pela linguagem, suas afetações e assim pensar o fenômeno psicossomático como resultado da holófrase³ dos significantes S1 e S2, conforme Lacan (1964/2008) apontou. Trata-se aqui de casos particulares e não de um modelo universal, mas que pode ser utilizado para pensar e construir a partir deles.

O interesse pelo tema surge da necessidade de aprofundar meus estudos sobre linguagem e corpo. Através de experiências clínicas e pessoais, percebo como o corpo se expressa de maneira singular nos diferentes casos e estudos.

Com a prática clínica, foi possível perceber de perto que, em alguns casos, o sintoma corporal é a forma do sujeito expressar suas angústias, medos e inibições. Vejo como fundamental compreender como o corpo é afetado por significantes e como o sujeito é formado por discursos desde antes de seu nascimento e continua sendo afetado por eles pelo resto de sua vida. Na psicanálise, principalmente em Lacan, o corpo não é visto apenas como biológico, mas também simbólico, marcado pela linguagem. O sujeito não nasce pronto, mas se estrutura através da linguagem, que nomeia e dá sentido ao corpo (Hartmann, 2023).

A pesquisa propõe uma análise dos efeitos da linguagem no corpo pelo viés psicanalítico, principalmente em casos do fenômeno psicossomático, visando compreender as formas de inscrição do sofrimento psíquico e a necessidade de oferecer alternativas clínicas que permitam a construção de uma narrativa sobre suas dores. Essa abordagem é apresentada como necessária para contrapor a tendência de silenciamento dos sintomas pela medicalização. Portanto, as questões norteadoras desta pesquisa são: Como a psicanálise compreende a relação entre corpo, significante e sintoma

³ A holófrase é uma forma de comunicação infantil em que uma única palavra é utilizada para expressar uma ideia complexa. É a fala de uma palavra, sendo os primeiros enuniados de entrada na língua materna (Santos, 2015).

psicossomático? E de que maneira a linguagem se inscreve no corpo e pode produzir sintomas?

1. Entre o somático e o psíquico: o enigma da pulsão

Introduzindo a pulsão no olhar da teoria freudiana, ela é vista como energia que emerge de um processo somático e requer trabalho do aparelho psíquico quando alcança a representação. Portanto, a pulsão está para além do inconsciente e consciente. É o que estimula o aparato psíquico, está em um lugar fronteiro entre o somático e o anímico. Caracterizada como energia livre de pura excitação que busca satisfação (Secotte e Dionisio, 2018). A pulsão não seria um simples elo de encontro entre o somático e psíquico, mas algo que não pertence inteiramente a nenhum dos dois. (Garcia, 2021).

Em *Além do princípio de prazer*, Freud (1920), atravessado pelo tratamento dos neuróticos de guerra, repensou a natureza da repetição do sintoma em detrimento do trauma. Nesta obra surge o conceito de pulsão de morte, uma energia que invade o psiquismo e pode interromper o funcionamento do eu, direcionando-o para o desejo de cessar todo desejo, levando à morte psíquica. Esse conceito representa, provavelmente, a primeira vez que se propõe a existência de uma energia capaz de gerar paralisia, sofrimento e destruição. Segundo essa ideia, enquanto as pulsões de vida (Eros) buscam a sobrevivência, o prazer e a reprodução, as pulsões de morte tendem à autodestruição e ao retorno ao estado inorgânico, um impulso silencioso em direção à quietude final.

Freud (1920) traz o exemplo da vesícula, que, em meio a choques incessantes de estímulos externos, poderia se modificar de maneira permanente. Isto explica como o organismo vivo interage com o ambiente externo e como o sistema nervoso central evolui a partir dessa interação. É importante a proteção contra estímulos nos organismos vivos, que enfrentam um mundo externo repleto de energias intensas. Para evitar serem danificados, os organismos desenvolvem uma camada externa, semelhante a uma membrana, que filtra e reduz a intensidade dos estímulos antes que cheguem às camadas internas sensíveis. Essa camada externa, embora inorgânica, protege as partes vivas do organismo, permitindo apenas a passagem de quantidades controladas de estímulos, essenciais para a orientação e entendimento do ambiente.

Nos organismos mais desenvolvidos, a camada cortical receptora de estímulos

recuou para dentro do corpo, enquanto os órgãos sensoriais permanecem na superfície, preparados para captar estímulos específicos. Esses órgãos também possuem mecanismos para evitar sobrecargas e filtrar estímulos inadequados, funcionando como "antenas" que exploram o ambiente com cuidado, recebendo apenas pequenas amostras do mundo exterior. A proteção contra estímulos é vista como uma tarefa crucial, permitindo que o organismo mantenha suas funções vitais sem ser destruído pelas forças externas (Freud, 1920). É possível observar uma explicação a partir do biológico, mas ainda assim importante para a compreensão da pulsão para o viés dos adoecimentos somáticos, possibilitando relacionar o que vem de fora ao que é interno.

Além de receber estímulos externos, o órgão e a psique também recebem excitações internas que criam tensão entre o que vem de fora e o que provém do interior do organismo. Enquanto os estímulos externos são filtrados e reduzidos, os internos circulam livremente e em maior quantidade, influenciando a sensação de prazer e desprazer (Freud, 1920).

Esta dinâmica apresenta duas principais consequências, a primeira é que os processos internos, prazer e desprazer, se sobressaem aos estímulos externos. A segunda consequência é que há uma tendência de evitar as excitações internas que causam desprazer excessivo, levando o organismo a perceber o estímulo interno como se fosse externo. Com essa distorção, ocorre a projeção, que desempenha um papel significativo no desenvolvimento de processos patológicos (Freud, 1920).

As excitações externas, quando são intensas demais a ponto de romper a proteção contra os estímulos, são chamadas de traumáticas, pois ocorre uma inundação no aparelho psíquico, que gera uma sobrecarga e requer uma resposta defensiva imediata. A dor física é considerada um exemplo de ruptura parcial dessa proteção, gerando uma reação energética significativa para tentar neutralizar o estímulo invasor. Esse processo envolve um "contrainvestimento" energético, retirando recursos de outras funções psíquicas, resultando em uma redução geral do funcionamento mental (Freud, 1920).

Apesar das dificuldades em compreender esses processos metapsicológicos, devido à falta de clareza sobre a natureza das excitações nos sistemas psíquicos, é possível considerar a hipótese de que também possa influenciar nos aparecimentos ou na intensificação de sintomas e doenças somáticas. Freud (1920) faz entender que os

processos excitatórios nos sistemas psíquicos e orgânicos deixam marcas com base na memória, estes são vistos como restos mnêmicos que diferem da consciência. Estas marcas podem ser mais intensas e duradouras quando o acontecimento que as criou não chega à consciência.

O processo pulsional não é visto como algo inato, automático ou regulado por um equilíbrio energético. Ele se constitui na historicidade das relações interpessoais com o Outro, proporcionando cuidado e autoconservação. A pulsão funciona como uma abertura para possibilidades no aparelho psíquico e funciona como um motor para o progresso psicológico. Porém, essa mesma pulsão tem características que desafiam o ego, causando desestruturação e conflito interno (Gutiérrez-Terrazas, 2002).

Através do processo psíquico, a pulsão pode atingir seu objetivo pela representatividade da linguagem. Sendo somente na relação entre eles que é capaz de ser executadas suas funções, desta forma não é possível supor que há pulsão sem representação ou vice-versa. Importante salientar que a total satisfação destas pulsões levaria à morte do sujeito, pois significaria a ausência de desejo. A diferença entre a quantidade de satisfação que é exigida e a que é conquistada é o que impulsiona o sujeito, impossibilitando a parada da pulsão. Com isso, compreende-se que sempre falta ou sobra um resto de prazer a ser conquistado. Esta satisfação inalcançável, na teoria lacaniana, é nomeada de objeto *a* (Secotte; Dionisio, 2018). O “entre” que está posto na definição de pulsão pode ser pensado no intervalo entre significantes, necessário para formulação da metáfora e possibilidade do sujeito surgir (Garcia, 2021).

A articulação entre pulsão de vida e pulsão de morte, tal como apresentada por Freud (1923/1996) pode ser pensada a partir da lógica de uma banda de Möbius. Sendo assim, não se trata de duas forças separadas, mas uma continuidade topológica. Isto é, aquilo que se apresenta como “dentro” e “fora” se revela como uma única superfície. Assim, a pulsão de morte não atua isoladamente, mas encontra vias de expressão justamente por meio da articulação com a pulsão de vida.

A teoria freudiana traz o ganho de prazer que é de outra ordem e está vinculado à repetição de alguma vivência desagradável. No Fort-da, brincadeira que Freud (1920) observou em seu neto que estaria representando simbolicamente a experiência de

desprazer ocasionada pelo desaparecimento da mãe, é desenvolvido que a repetição do menino em sua brincadeira representa sua tentativa de elaboração e de dar sentido a uma experiência negativa, inassimilável. A repetição de cenas traumáticas através do sonho também foi considerada por Freud como um retorno à vivência desprazerosa na tentativa de elaborá-las.

Lacan (1988), em *A ética da psicanálise*, traz sua leitura diante do conceito de pulsão de morte de Freud, dando um sentido não apenas biológico, mas estrutural e simbólico. Portanto, a morte é pensada como a entrada do sujeito na ordem simbólica a partir da condição estrutural da linguagem, estando ligada ao funcionamento do significante. O sujeito, ao entrar no simbólico, precisa passar por uma perda de algo do real, um esvaziamento para que o simbólico possa se formar.

Essa coisa que é perdida é o que coloca o sujeito em uma busca infindável e é o que possibilita o desejo. Freud (1895/1950) já tinha introduzido um componente psíquico que fica de fora, está mais além do princípio do prazer, assim como o conceito de gozo apresentado por Lacan. Pensando na repetição atribuída à pulsão de morte, Lacan desenvolve o conceito de gozo, como uma forma de tentar dominar o real (Hartmann, 2023). Mais adiante será abordado o conceito de gozo em Lacan, primeiro será pensado o corpo em psicanálise, para além do biológico e articulado com a linguagem.

2. Estádio do Espelho e a Construção do Eu Corporal

Para pensar o corpo em psicanálise, é preciso ter em mente que o corpo é o primeiro a produzir sentido, a partir das nomeações realizadas pelos cuidadores, o bebê constitui o “Eu”. O sentido construído no corpo vem da cultura, das relações, de discursos já existentes que são endereçados ao bebê (Hartmann, 2023). Sendo o primeiro corpo formado por significantes, corpo da linguagem, se opondo à ideia de corpo biológico, consideramos a ideia de discurso lacaniano, este dispositivo seria responsável por enlaçar o sujeito e o social (Safatle; Silva Junior; Dunker, 2018).

O corpo para a psicanálise está para além do biológico, aqui o corpo é visto como pulsional, erógeno, atravessado pela linguagem. Mas o que significa ser atravessado pela linguagem? Quer dizer que o sujeito já existe antes de nascer, já é falado sobre ele pelos

pais e familiares, há um imaginário constituído de significados e significantes que integram sua subjetividade e isto parte de uma relação com o Outro (Oliveira e Winter, 2019). Trata-se do corpo no seu aspecto pulsional, situado entre o somático e psíquico, envolve o objeto a, assim como a imagem corporal, constituída no estágio do espelho.

Para explicar melhor esse estágio, partimos do ponto que inicialmente o corpo encontra satisfação nele próprio pelo autoerotismo do bebê, logo após é formado o corpo narcísico primário que direciona parcialmente a pulsão para um objeto externo. Esse direcionamento busca um corpo completo, que seja semelhante ao seu. Nesse processo de direcionar a libido para outros objetos, é constituído o narcisismo secundário, quebrando com o eu ideal imaginário e formando o ideal de eu. O narcisismo primário é deixado para trás após o complexo de Édipo e a castração, pois é nesse momento que a criança se depara com as leis externas, rompendo com a alienação narcísica e voltando para o mundo (Oliveira e Winter, 2019).

No campo psicanalítico, o corpo pode ser pensado em uma estrutura dos três registros de Lacan, o Imaginário, o Simbólico e o Real. Ocupando-se de conceitos freudianos como ego, narcisismo e identificação, Lacan buscou desenvolver seus estudos sobre a constituição do Eu, implementando o esquema do estágio do espelho, elaborou o registro Imaginário. A percepção imaginária de unidade corporal antecipa o desenvolvimento fisiológico e motor no indivíduo. Esta fase de reconhecimento e distinção entre seu corpo e o mundo externo constitui a subjetividade do sujeito (Lacan, 1953/1998). É mostrada aqui a antecipação do funcionamento psíquico em relação ao corpo orgânico para formação de unidade corporal. A experiência do espelho leva a criança a reconhecer uma suposta unidade corporal que orienta a experiência com o próprio corpo marcada por descoordenação motora e sensação de fragmentação (Sales, 2005).

Lacan (1953/1998) deixa claro que o sujeito constrói uma solução ilusória diante da angústia do despedaçamento, é uma imagem idealizada, alienada e que nunca alcança a plenitude, pois a imagem apresentada no espelho nunca corresponde fielmente a realidade corporal, desde o início ela é distorcida, deixando em evidência a distância entre a realidade e a imagem de identificação. A função do Eu, como construção imaginária, é organizar a experiência do sujeito, mas que o divide. Há uma alienação em que o espelho representa o Outro e o sujeito vê o eu ideal como objeto de desejo do

Outro.

No texto *O estádio do espelho como formador da função do eu*, Lacan (1953/1998) descreve que, diante da imagem refletida no espelho, a criança manifesta a expressão de júbilo. Nesse momento, há a identificação que pode ser definida como a transformação do sujeito ao assumir uma imagem. Essa transformação inaugura a formação do “eu”, o sujeito tem a percepção de uma imagem que lhe é dada a partir do exterior. Essa primeira forma, “eu ideal”, é matriz para as próximas identificações responsáveis pela fixação do modo de ser. Essa armadura da identidade alienante é o que irá marcar a estrutura do seu desenvolvimento mental.

Sendo formado a partir de uma imagem exterior a si mesmo, o “eu”, desde sua gênese, revela-se como uma instância estruturalmente paranóica, seja qual for a forma sintomática que irá manifestar posteriormente (Sales, 2005). Pensando no processo de alienação que Lacan citou, pode-se questionar o que ou quem ocupa o lugar do espelho e da imagem no qual o Eu se reconhece e ao mesmo tempo se aliena, se perde? Para responder, é necessário diferenciar o outro (letra minúscula) do Outro (letra maiúscula). O chamado “pequeno outro” é referido ao semelhante, aquele que oferece a primeira forma de identificação. Sendo assim, a imagem refletida no espelho indica o outro semelhante e é por meio deste que a criança apreende sua imagem corporal. O “Grande Outro” vem como um terceiro elemento na metáfora, o espelho. E pode ser compreendido como a linguagem, a cultura ou o registro simbólico (Imanishi, 2008).

Em um momento seguinte, foi introduzido o registro simbólico no estádio do espelho, mas vale ressaltar que este registro está articulado com o Imaginário. O registro simbólico é determinante, pois está sempre presente, mesmo antes do Imaginário se concretizar. Ainda que a criança não possua capacidade de simbolização, ela é simbolizada pelos outros à sua volta. Desta maneira, o Simbólico está posto nas expectativas dos pais e no discurso social antes da criança nascer e o corpo biológico existir. Sendo assim, o corpo que interessa para o campo psicanalítico não é o corpo biológico, mas aquele composto por linguagem (Cukiert; Prizskulnik, 2002).

A conquista da imagem do corpo próprio é compreendida por Lacan (1953/1998) não só como um processo de maturação orgânica, mas que implica necessariamente a intervenção ou presença de um outro. É este outro que introduz a criança na linguagem,

com as demandas de cuidado por parte do bebê, aquele que ocupa a função de cuidador inscreve marcas simbólicas e atribui significados às sensações e comportamentos da criança. Assim, ao falar de sujeito, estamos falando de reconhecer o eu constituído na relação com o Outro, assujeitado ao seu desejo e ao simbólico que ele representa.

Lacan (1978/1987) em *O eu na teoria de Freud e na técnica da psicanálise* aborda que “A função simbólica constitui um universo no interior do qual tudo o que é humano tem de ordenar-se”. Em outras palavras, o sujeito é efeito do simbólico, através do registro da linguagem é que o sujeito vai deslizando na cadeia significante, deslocando-se do centro de qualquer identidade (imaginário).

Em *Os Escritos Técnicos de Freud*, Lacan (1986) vai introduzir o registro do Real como aquilo que escapa da simbolização, ou seja, que fica fora do domínio da imagem e da palavra. Em *O eu na teoria de Freud e na técnica da psicanálise*, vai articular o real com os outros dois registros, imaginário e simbólico, na intersecção dos três registros é que o sujeito se constitui. Mais adiante em sua teoria, no seminário *Os quatro conceitos fundamentais da psicanálise*, Lacan (1964/2008) vai descrever o Real como da ordem do impossível, como aquilo que nunca cessa de não se inscrever. Em outras palavras, o registro do Real é visto como uma realidade inacessível ao pensamento.

Seguindo com a teoria, o estágio do espelho acrescenta o registro do Real, colocando o objeto *a* no lugar do Outro. O objeto *a* seria representado pelo olhar do Outro, algo que escapa (Cukiert; Prizskulnik, 2002). Neste sentido, percebe-se o desconhecimento do Eu, retirando a consciência do lugar central, já que o Eu é construído a partir do outro, mostrando uma alienação frente ao seu próprio desejo.

Sendo impossível de ser simbolizado, o real aparece na estrutura psíquica como um buraco, uma falta. Esse vazio se manifesta de duas formas: no Imaginário, como a ausência de um saber instintivo (diferente dos animais, o ser humano não nasce com um manual biológico de comportamento); e no Simbólico, como a falta de um significante que poderia dar conta plenamente do desejo e da identidade, que está vinculado ao campo do Outro (Ferreira, 2002).

De acordo com o que foi dito até aqui, é possível pensar que cada pessoa trará em seu corpo uma estrutura formada através das suas vivências subjetivas do corpo. A imagem de si apresenta uma instabilidade desde a constituição do Eu, que transita entre

o eu e o Outro. Ribeiro (2010) salienta que uma falha no estádio do espelho pode fazer com que o indivíduo busque modificações voluntárias ou involuntárias no próprio corpo como forma de diferenciação do outro, já que não houve esse olhar do Outro que o diferenciase e reconhecesse para restauração narcísica no estádio do espelho.

A busca por corrigir a fragmentação interna traz uma sensação de unidade, mas este corpo fragmentado persiste no inconsciente através de sonhos e sintomas. Logo, o sujeito se torna dividido em dois polos de luta, o Eu Ideal e o Ideal de Eu (Lacan, 1953/1998). O desejo é estruturado na linguagem e implica uma divisão interna no sujeito.

Em suma, a imagem de si forma-se através de um olhar externo, um terceiro que faz triangulação na relação eu-outro. Na falta deste olhar, o sujeito ficaria preso no transativismo do imaginário (Barroso, 2015). Isto é, há uma confusão do próprio corpo com o do outro, dificultando a distinção entre si e o mundo externo. Artigo aqui o vai e vem da pulsão, “é ver e ser visto, atormentar e ser atormentado” (Lacan, 1864/2008, pg. 175), é disto que trata a vida, um percurso de enlaçamentos de discursos, afetos, olhares. O olhar aqui ocupa uma função importante já que a experiência especular não se reduz ao ver-se, mas principalmente de ser olhado. Esse olhar não se localiza um ponto fixo, não é olhar que ocupa um lugar de linguagem e desejo. A imagem especular pode ser entendida como um momento em que o sujeito tenta dar borda a invasão do olhar do Outro, como forma de delimitar o corpo.

Percebe-se que o espelho é usado aqui como uma metáfora, é neste momento que ocorre a primeira relação consigo e que está inevitavelmente e sempre relacionada ao outro. Esta fase não será apenas uma fase cronológica a ser superada, mas que vai ser um exemplo de como o desenvolvimento do ser humano irá ocorrer. É um momento lógico de constituição do sujeito.

Em suma, podemos ver que o sujeito dividido se diferencia do Eu. O Eu é marcado pela ideia de unidade, tenta manter uma aparência de coerência através do imaginário. Já o sujeito diz respeito ao inconsciente e ao desejo, é efeito de significante. Quando é retomado o cogito cartesiano, no estudo lacaniano, foi justamente para criticar e introduzir uma diferença entre ser e pensamento. Se Descartes pensava que o sujeito existe no pensamento, a psicanálise vai mostrar, através do inconsciente, que o sujeito é onde não pensa, pois as formações como sonhos, atos falhos, chistes, lapsos mostram que o

pensamento consciente não define o sujeito, mas que é efeito (Bruder e Brauer, 2007).

Na língua francesa, Lacan consegue expressar essa distinção entre *moi*, que se refere ao eu imaginário, e *Je*, que aponta a posição do sujeito como enunciação. O sujeito, portanto, se constitui no intervalo onde o pensamento escapa, na falha, é produzido na incidência da linguagem. No seminário 11, Lacan (1964/2008) vai salientar duas operações: alienação, onde o sujeito surge quando integra a rede significante, mas perde algo de si; e separação, em que o sujeito se constitui quando articula-se ao desejo do Outro. Aqui a divisão do sujeito se faz presente, some a certeza cartesiana e aparece um ponto de fenda. É um enigma que marca a divisão que descentra o indivíduo e a razão, se faz necessário compreender essa diferença para as possibilidades da prática psicanalítica. Não se trata do eu psicológico, mas de uma posição que surge entre um significante e outro (Bruder e Brauer, 2007).

O sujeito barrado, portanto, é o sujeito atravessado pela linguagem e não coincide consigo mesmo, sendo assim o corpo tampouco é uma totalidade fechada ou autossuficiente. Ele é sustentado pelo enodamento entre os três registros, suficientemente consistente para garantir sua continuidade, mas sempre passível de falha. É neste ponto que podem ser pensadas as palavras totalidade ou unidade apenas de modo ilusório. Quando a amarração dos três registros vacila, surgem manifestações que escapam à ordem do sentido, isto revela que nem o simbólico, nem o imaginário recobrem inteiramente o real do corpo (Lacan, 1975/1985).

3. Relação entre Corpo e Linguagem, a teoria de Jacqueline Authier-Revuz

Nos limites entre o interior e o exterior de uma palavra, o que está em questão é o papel fundamental, para o sujeito, da relação entre corpo e linguagem. Essa relação envolve o sentimento que sustenta sua identidade e o define como uma entidade distinta. O sentimento de ter um "corpo próprio" não é algo inato ou imediato ao nascer. O simples fato de nascer, embora marque uma separação física, não garante que o indivíduo se perceba como uma unidade distinta. Para que isso aconteça, é preciso que cada sujeito construa uma imagem coesa de seu próprio corpo, um processo que envolve a formação da identidade. Esse caminho de individuação não é automático nem linear, pois pode ser atravessado por dificuldades e até fracassos, influenciando diretamente a forma como

cada pessoa estrutura seu "eu" (Authier-Revuz, 2020).

O ser humano, quando nasce, já está imerso na linguagem, mesmo antes de seu nascimento, está cercado por uma rede de discursos que o acolhe e também o aprisiona (Lacan, 1953/1998). O sujeito, ao se tornar falante, sabe-se que muito antes de falar uma palavra própria, foi falado, banhado, tecido e ferido pela linguagem. Por ter sido um infans, foi também um corpo de alguém, ao redor de alguém. A construção e a forma da imagem do corpo se desenvolvem no contexto da linguagem que o envolve.

Como foi dito, o estágio do espelho representa um momento em que a imagem corporal fragmentada que a criança tem se unifica por meio do espelho e do olhar do Outro. Essa unificação psicossomática é iniciada por uma imagem, mas sustentada pelo simbólico e o processo relacional (Authier-Revuz, 2020). É nas relações (fora) que o Eu (dentro) é formado e constantemente modificado. A imagem de si é alienada através do Outro. Ao mesmo tempo que é necessário ter essa individuação, distinção do Outro, é preciso se afastar da separação radical, isto é, o Eu se mantém no equilíbrio entre o dentro e fora.

A necessidade do sujeito de estabelecer uma fronteira dentro/fora é indissociável dos distúrbios psíquicos relacionados a um defeito nessa fronteira, mente/corpo, eu/mundo. Essa diferenciação não deve ser separada por um muro, mas vista como um litoral, onde há possibilidade de troca entre um lado e outro. Não é uma fronteira dada, nem fixa. Tudo que a toca a afeta e é afetada de volta, está em constante movimento, podendo no decorrer da história do sujeito ser modificada (Authier-Revuz, 2020).

"Nossa fala não é "nossa" da mesma forma que nosso corpo", assim diz Authier-Revuz (2020). A fala, ao mesmo tempo que possui uma singularidade daqueles que a enunciam, também é constituída a partir do externo, uma fala que se desloca entre um e outro. À medida que o Eu-corporal se constitui, ele o faz por meio de um processo de separação psicológica da simbiose originária. No entanto, a fala que surge nesse contexto – que poderíamos descrever como algo que "toma corpo" – não pode ser dissociada do ambiente linguístico no qual se insere e do qual é formada.

Em suma, o sujeito não é totalmente autônomo, pois há um Outro dentro de si que o influencia. Esse Outro não se limita a um interlocutor externo, mas corresponde ao próprio inconsciente, estruturado como linguagem. Como afirma Lacan, "o inconsciente é

o discurso do Outro", o que significa que o desejo do sujeito sempre se articula em relação ao desejo do Outro. Em outras palavras, o desejo nunca é algo puramente individual, pois está sempre mediado pelo campo simbólico, pelo olhar e pela linguagem do Outro.

Quando a criança nomeia seu corpo como "Eu", ela está se inserindo na rede da linguagem. O corpo é a primeira forma de construir um sentido, mas esse sentido está ligado diretamente ao meio em que ele está e às vivências dele. As emoções, os membros do corpo, as necessidades fisiológicas, todas as nomeações, vêm de fora, da cultura (Hartmann, 2023). A fala daquele que cuida despeja um fluxo que contém um sentido que antecipa a capacidade da criança em reconhecer o significado.

No seminário *Mais, ainda* (1975/1985), Lacan apresenta um novo estatuto para a noção de corpo, através do conceito de falasser (*parlêtre*) ou também conhecido como ser falante. Este conceito indica o sujeito não apenas como efeito da linguagem, mas também é falado por ela, constituído e marcado por ela no seu próprio corpo. Como já vem sendo discutido aqui, desde o início da vida, o sujeito é atravessado pela língua materna, composto por um conjunto de sons carregados de afetos e desejos, vindos do Outro.

Sendo assim, os significantes da língua materna sempre serão do campo do simbólico, pois depositam no corpo suas marcas, produzindo efeitos concretos, como modos de sentir, sofrer, gozar. O corpo do falasser está preso e determinado por significantes, e tornando-o assim um corpo afetado pela linguagem (Quinet, 2009). Desde o seminário *Mais, ainda* é que Lacan foi constituindo uma nova articulação entre corpo e gozo.

4. Sintoma e Fenômeno Psicossomático: Diferenças e semelhanças

Acrescento agora o conceito de imaginarização do real que Dunker (2021) traz para nos ajudar a pensar os fenômenos psicossomáticos, onde o sujeito busca representar ou traduzir o real no campo imaginário. Esse processo pode envolver uma tentativa de dar sentido ao que é traumático, já que o Real, em muitos casos, é vivenciado como algo perturbador ou impossível de ser totalmente capturado pela linguagem. Pode ser visto como um mecanismo de defesa que, através de imagens, fantasias, narrativas simbólicas ou sintomas físicos, auxilia o sujeito a lidar com aquilo que foi traumático.

Dunker (2021) reconhece que há diferentes formas de separação e alienação do corpo. Nos adoecimentos ditos psicossomáticos, é comum encontrar uma memória sem história; os sintomas respondem a datas, locais, lugares, formas simbólicas familiares e sobre estes há geralmente reincidências dos sintomas, repetições. Mas o analisante não possui uma potência narrativa para estas memórias. Há uma transformação no corpo, que representa uma forma inversa, por exemplo, da passagem ao ato.

Os fenômenos psicossomáticos representam uma interação do corpo consigo mesmo, como alergias respiratórias crônicas, retocolite ulcerativa, psoríase, vitiligo, entre outras. Dunker (2021) vai dizer que nem todas as lesões de órgão são de formação psicossomática, considerando o campo psicanalítico. Contudo, o autor aborda que é comum em todos os casos a imaginarização do real, com um isolamento do simbólico. No entanto, vemos nos casos apresentados que pode haver um excesso de sentido ou totalização do sentido, que vem do Outro. Seria um excesso de imaginário, isto é, um sentido único, tem a ver com reconhecimento, se identificar, se deixar capturar, alienar. Também pode estar na posição de engano, ideia tomada como identidade. Assim como a criança é capturada por sua imagem no espelho, construindo um senso de unidade. O que parece ocorrer é um fechamento à alteridade e uma limitação das possibilidades discursivas que permitem o deslocamento do gozo, mas não um isolamento do simbólico.

Pensando na imaginarização, seria quando o sujeito opera predominantemente no registro Imaginário, ele se fixa em identificações rígidas e imagens especulares, perdendo o apoio que o discurso pode oferecer na relação com o Outro, sustentando a falta constitutiva (Bacelar & Coutinho, 2022). Essa amarração entre os registros do simbólico e imaginário é que determina o gozo do sentido. Não necessariamente implica que há ausência de Outro, mas abre espaço para o excesso de sua presença, sendo visto como algo insuportável de digerir, de fazer laço.

Quando Lacan (1962-1963/2005) trabalhou o simbólico como borda do gozo, foi mostrado que é justamente na articulação dos significantes que é possível conter a invasividade do Outro. Se não há essa articulação, ocorre algo parecido com o que Lacan (1975-1976/2007) chamou de holófrase, que é quando os significantes não se encadeiam, ficam colados. Esse significante que atua como ponto de impacto é onde o Outro invade o sujeito ao invés de estruturar seu desejo. Isto é, ao fechar-se às operações discursivas,

o sujeito perde justamente a borda que poderia ordenar seu gozo e a relação com o Outro e sua alteridade. Sem essa borda o significante impacta o corpo de forma direta, produzindo uma resposta através do sintoma físico. É precisamente nessa direção que o fenômeno psicossomático pode ser pensado. Não é simplesmente falta de simbolização, mas a incidência de um significante que se inscreve de maneira direta, sem metáfora, fixando-se em uma determinada parte do corpo. O significante que toca o corpo gera uma marca sem mediação.

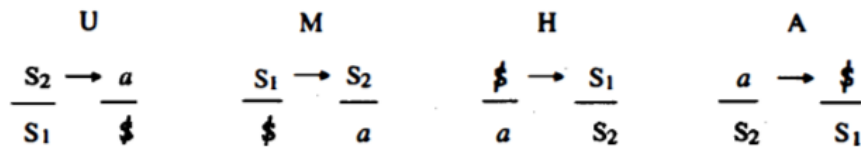
Retomando um pouco o que foi abordado anteriormente, o sujeito é inserido na linguagem e nela se articula a partir de significantes. Pensando nisso, o S1 é o traço unário que instaura a cadeia significante, representa o sujeito, é o que o marca como uma espécie de tatuagem simbólica. Essa constituição do significante ocorre em três tempos: primeiro há inscrição de um traço, sendo a primeira marca recebida pelo Outro. Em um segundo momento, há o apagamento, ou o recalque, como proposto por Freud, desse traço da consciência. No terceiro momento, é quando o sujeito pode dizer de si através de interpretações de marcas que já foram inscritas (Garcia, 2021). Com esses tempos e através do rastro deixado, é possível sustentar a função significante. No terceiro momento citado, penso que o sujeito não diz sobre si, mas surge como efeito das articulações desses rastros, dos significantes.

Sendo assim, o significante, a partir de sua introdução, afeta o corpo e se torna corpo. Captado de Outro, reflete sobre o corpo do sujeito, fragmentando-o e produzindo o mais-de-gozar. Ao introduzir esse conceito, Lacan (1968-1969/2008) faz referência à mais-valia de Marx. A mais-valia é um termo utilizado para apontar a disparidade entre o valor do trabalho produzido pelo trabalhador e o salário pago a ele. Ou seja, o valor excedente do trabalho feito pelo trabalhador e é apropriado pelo capitalista é o que constitui a mais-valia, já que a força de trabalho cria mais valor do que custa em salário. Essa diferença constitui a base do lucro do empresário e expressa o funcionamento de exploração do capitalismo.

Lacan (1968-1969/2008) a partir disso pensa o mais-de-gozar, compreendendo que o sistema não busca a satisfação, mas o acréscimo contínuo, a repetição do ganho. É o resto de gozo interditado pela linguagem, é o objeto *a*. Em *O Averso da Psicanálise*, Lacan (1969-1970/1992) vai apresentar os quatro discursos, onde o objeto *a* se faz presente como

mais-de-gozar. O discurso presume a perda de um objeto que deve retornar como um objeto a ser recuperado, ou seja, é o gozo perdido que precisa ser recuperado e que retorna como mais-de-gozar. Desta forma, o objeto *a* pode ser compreendido como o objeto que pode se apresentar como objeto de gozo, além também de poder ser causa do desejo. E é assim que o objeto *a* se faz presente em todos os discursos. Em sua articulação com S1 e S2, são inscritas formas de relações (Garcia, 2021). Para pensar os discursos apresentados nos casos, trago à luz a teoria dos quatro discursos de Lacan, como mostrado na figura 1:

Figura 1 – os quatro discursos (1969-1970/1992):



Abaixo, na figura 2, estão os lugares de cada um, como aparece em Lacan no seminário 17 (1969-1970/1992):

Os lugares são:



Figura 2:

Esses quatro discursos são laços sociais que giram ao redor de um impossível. O Discurso do Mestre representado pela letra M, é onde o significante mestre (S1) ocupa o lugar de agente, e o saber (S2) ocupa o lugar do outro que produz um efeito de satisfação, um mais-de-gozar (objeto *a*), o sujeito (S/) neste caso ocupa o lugar da verdade, isto é, é aquilo que não pode aparecer, esconde o sujeito dividido, atrás do discurso do mestre, do poder.

Ao fazer uma regressão do Discurso do Mestre, há então o Discurso Universitário, onde o S1 passa a ocupar o lugar da verdade e o S2 o lugar de agente, o sujeito ocupa o lugar da produção e o objeto *a*, a posição do outro. Sendo assim, o Discurso Universitário trata o outro como objeto a ser moldado (Lacan, 1969-1970/1992).

A partir do Discurso do Mestre, é possível girar progressivamente, colocando o S1

no lugar do outro, S2 no lugar de produção, o sujeito barrado no lugar do agente e o objeto a no lugar da verdade, formando assim o Discurso Histérico (Lacan, 1969-1970/1992).

Seguindo com a progressão do Discurso Histérico, surge o Discurso do Analista, que coloca no lugar o semblante ou agente, o objeto a que é a posição do psicanalista. Pois o analista se coloca como suporte para a fantasia do analisante, no lugar do outro está o sujeito e na produção fica o S1, é o que o analista vai trabalhar para desalienar o sujeito de seus significantes mestres, no lugar da verdade ocupa o saber, um saber que não se sabe (Lacan, 1969-1970/1992).

Quando o significante mestre fica colado no saber, prende o sujeito nesse intervalo. Ficando ao nível do gozo do Outro, isto é, o Outro detém o gozo absoluto e o sujeito fica demasiadamente identificado com a demanda, o saber ou os ideais que fazem o Outro ser intrusivo demais para si. Ocorre, então, um curto-circuito da linguagem, fazendo com que pareça que o corpo não precise de linguagem, mas ela está lá, de alguma forma os significantes ficam colados em um significado sobre o corpo.

Como está sendo abordado até aqui, o corpo é escrito no simbólico, através da nomeação, como traço que singulariza o sujeito. Aqui, o corpo pode ser designado por nome próprio, símbolos, marcas linguísticas que identificam esse corpo entre vários. A nomeação recorta, localiza, estabiliza o sujeito na cadeia significante. O corpo então aparece naquilo que dele é dito, reconhecido e inscrito na ordem da linguagem. É o corpo como efeito (Nasio, 2009).

Sendo assim, a hipótese de holófrase que Lacan (1975) aborda como sendo o S1 colado ao S2, impedindo a abertura para a cadeia significante, me permite pensar que uma marca pode fixar o discurso que tece o corpo. Pois quando o significante aparece em uma articulação única, fixada, que não desliza, não possibilita outras metáforas, ele não produz novos sentidos e permanece em um único ponto, é nesse ponto que é favorecida a inscrição no corpo como resposta a essa estagnação. Em Branco, Abeche e Pinheiro (2021), termo holófrase que Lacan propôs foi elaborado a partir de Mannoni, onde foi trabalhada a fusão de corpos entre a mãe e a criança. Lacan, desenvolvendo a teoria a partir disto, passou de fusão de corpos para fusão de significantes primordiais.

Retornando ao estágio do espelho, podemos pensar a imagem especular, conceito que Lacan (1998) designa como responsável por oferecer unidade ao corpo nesse processo

de gozo do Outro. Penso que, quando o sujeito se vê capturado por um significante mestre, acaba não deixando espaço para que a imagem do eu se estabilize. Pode haver uma desorganização ou rigidez da imagem especular. Nesse cenário, o significante torna-se rígido e captura o sujeito, não permitindo a circulação ou diferenciação. Impede a abertura para o desejo. Produz uma espécie de fechamento subjetivo no qual o sujeito dividido não encontra possibilidade de deslizar na cadeia significativa.

Quando Lacan (1995) tratou dos processos que constituem o sujeito, o autor discutiu o estágio do espelho como uma conjuntura que ilustra os conflitos das relações, pois há uma distância entre o corpo vivido como fragmentado e a imagem unificada construída posteriormente com sua relação com o mundo exterior e seus semelhantes. Este processo marca o olhar que Lacan tem sobre o sujeito, pois vai além do puro organismo biológico, precisa-se de investimento libidinal para ser constituído um corpo pulsional. Neste investimento e constituição do eu, o sujeito perde uma parte de si que pode futuramente simbolizar o objeto perdido (Lacan, 1964/2008). O que isto quer dizer é que desta hiância não se produz apenas energia libidinal, mas também cai dela um objeto no qual marca o sujeito dividido, produzindo assim a procura de uma satisfação pulsional.

Dois momentos fundamentais que se estruturam em relação ao Outro é a alienação e a separação. A alienação é o que indica que o sujeito só pode surgir submetendo-se ao campo do Outro, e com isso falo do sistema de significantes que o antecede. Para exemplificar melhor Lacan (1964/2008) utiliza a metáfora que envolve o ser e o sentido, isto é, sempre que um elemento é escolhido no conjunto do sentido, que um significante é assumido, algum elemento equivalente se perde no conjunto do ser, ficando de fora, permanece no campo do inconsciente.

Desta forma, tem um movimento que é duplo, onde o sujeito ganha sentido e adquire uma forma de unidade simbólica, ocorre também um *fading*, um desaparecimento. Esse desaparecimento é o que Lacan (1964/2008) chama de afânise, que constitui um ponto importante da formação do sujeito, pois marca uma divisão que permite a dialética do sujeito. Para haver um sujeito, é preciso que algo se perca, algo precisa permanecer fora da representação. Esse conteúdo que escapa, fica no registro do Real, é aquilo que não pode ser simbolizado.

De difícil definição, o Real é trabalhado por Lacan como aquilo que resiste à

simbolização. Não corresponde a uma última essência que estaria por trás de tudo, mas algo que deve permanecer excluído para que o mundo possa aparecer como “organizado” e apreensível para o sujeito (Branco; Abeche; Pinheiro, 2021). Voltando com os três registros, percebe-se que é difícil falar de simbólico e imaginário sem que escape algum aspecto de um ou de outro, mas é porque justamente eles não são totalmente dissociáveis. Portanto, o Real apareceria na fronteira entre esses dois registros, é aquilo que ao mesmo tempo que enlaça, e o que não se ajusta, permanece fora do lugar.

Esse estar “fora” é o que aparece nas relações entre significante e objeto. No geral, é criado um encadeamento onde um significante remete a outro, o que permite a queda do objeto e a ascensão da representação que se relaciona ao Simbólico (Lacan, 1975/2007). Nesse processo acontece uma primeira expulsão do Real para fora do sujeito, no segundo momento é instaurada a discriminação da realidade, produzida pela percepção imaginária da primeira. Nisto, algo pode escapar ao princípio do prazer, mas não ao Real, que permanece como exterior absoluto, excluído da simbolização primordial (Lacan, 1966/1998b).

Sendo assim, pode-se pensar que certos fenômenos, como alucinação ou a lesão de órgão, podem escapar do princípio regulatório da economia psíquica e da estrutura significante, mas não do Real. “O que não veio à luz do simbólico aparece no Real” (Lacan, 1966/1998b, p. 390). Quando os significantes deixam de se encadear e não remetem mais uns aos outros, acabam por não produzir afânise, não há hiância e nem equívoco que coloque o sujeito em jogo. Com isso, parece que a solução encontrada é surgir no Real, nestes casos abordados, é na lesão de órgão.

Nas formulações sobre o *Sinthoma*, Lacan, na conferência de Genebra em 1975, retoma as questões dos fenômenos psicossomáticos e afasta uma discussão centrada em estruturas clínicas e foca na especificidade do modo de inscrição nesses fenômenos. Pelo que nos parece, de acordo com o discutido até aqui, é que trata-se de uma marca psíquica induzida por um significante que produz efeitos no sujeito, é uma escrita que opera como assinatura.

Nesta mesma conferência, Lacan (1975) vai comparar os adoecimentos psicossomáticos a um traço, se aproxima mais da lógica do número por indicar uma inscrição menos flexível. Desta forma, parece que o gozo não circula, fica congelado no

corpo. Novamente nos remetendo à noção de holófrase.

Pensando nesse congelamento do significante no corpo, pode-se conceber o sintoma como sendo um operador capaz de dar borda a esse gozo, assumindo a função que seria do encadeamento de significantes. É um elemento que irá amarrar os três registros do Real, Simbólico e Imaginário, oferecendo uma consistência mínima para o sujeito organizar sua relação com o gozo de forma singular (1975-1976/2007). O recurso ao corpo aparece como uma solução para lidar com o gozo que não é devolvido para o externo, não há um destinatário, diferente da histeria que remete a um Outro e deseja ser decifrado.

É importante distinguir que, em todos os casos, existe alguma via que é de escoamento pulsional. Quando os significantes estão congelados, a pulsão acaba por procurar outros recursos disponíveis. Se a via encontrada for o corpo, a lesão pode operar como um ponto de laço para o sujeito, seja por questão estrutural ou diante de circunstâncias específicas (Branco; Abeche; Pinheiro, 2021).

Retomando Lacan (1975) na conferência de Genebra, ao falar sobre o tipo de gozo que se encontra no psicossomático, traz que o “corpo se deixa levar a escrever algo da ordem do número”. O número, é aquilo que “atua como pura frequência, um sinal unívoco de cifra, contagem de gozo, que aponta para uma possível escrita do real” (Garcia, 2021, p. 107). Quando Lacan (1975) aproximou os fenômenos psicossomáticos à lógica do número, ele sublinha justamente essa rigidez da marca e a ausência de hiância. Essa aproximação do psicossomático com o número surge pela rigidez de lugar do número na série de números, de algo que está no mesmo lugar, por exemplo, mesmo local do corpo afetado.

A esse ponto, a proposta de Lacan (1971–1972/2012) é que, quando a articulação significante se encontra impedida de alguma forma, a inscrição do gozo assume um funcionamento parecido com o do número. Não é número enquanto quantificação, mas enquanto um agente de identidade que é idêntico a si mesmo e depende do seu lugar na cadeia significante, se relaciona a um lugar fixo, por exemplo: o quatro sempre vai estar entre três e cinco. Pode-se pensar que é justamente essa invariância que pode ser aproximada dos fenômenos psicossomáticos na lógica numérica, pois é uma marca que insiste no corpo e apresenta-se como Um que retorna sempre no mesmo ponto, no mesmo

lugar fora do encadeamento significante.

Outro termo que Lacan (1975/1985) propõe é *lalangue* (Alíngua), este serve para se referir à língua na sua dimensão de gozo. Diferenciado de *la langue* (a língua) que é objeto de estudo da linguística, a *Alíngua* é associada à língua incorporada por cada sujeito, seja esta composta por sons, equívocos ou trocadilhos, mas que deixam marcas corporais. Não é uma língua apenas para comunicação, mas também é fonte de gozo.

O sintoma é a marca que vai ligar o corpo ao Outro da linguagem, como um “umbigo”, essa metáfora está relacionada ao enigma do sonho em Freud, o que resiste à interpretação. O “umbigo do sonho” foi retomado por Lacan (1964/2008), tornando-se o nome do real do inconsciente, ou seja, é um ponto opaco em que a linguagem e o corpo se enlaçam de forma singular. Este é o mistério do corpo falante, aquilo que escapa das significações, também o constitui.

Dessa forma, a entrada do sujeito na linguagem implica a inscrição de marcas no corpo, evidenciando que o processo não se constitui de forma neutra. O sujeito quando aprende a falar, é afetado de maneira irreversível pelos significantes e isso produz efeitos que constituem o corpo falante. Estes efeitos irão se manifestar de maneiras diversas e de acordo com cada vivência (Quinet, 2009). O falasser é, então, o ser cuja carne foi tocada pela palavra e o sintoma é a marca dessa travessia, é a escrita do real sobre o corpo. Assim, quer se trate de uma criança ou adulto, falamos todos a linguagem já vivida anteriormente em nosso corpo quando criança, fala através do corpo às vezes sem ter consciência disso (Nasio, 2009).

Segundo Lacan (1975/1985, p. 149):

O corpo, ele deveria deslumbrá-los mais. De fato, é o mesmo que deslumbra a ciência clássica - como é que ele pode funcionar assim? Um corpo, o de vocês, não importa que outro aliás, corpo que se movimenta para lá e pra cá, é preciso que ele se baste. Alguma coisa me fez pensar nisto, uma síndromezinha que vi sair da minha ignorância, e que me foi lembrado - se por acaso as lágrimas parassem de correr, o olho não funcionaria mais muito bem. É o que chamo de milagres do corpo. Isto logo se sente. Suponham que ela não chore mais, que ela não sore mais, a glândula lacrimal - vocês terão aporrinhações.

Ao afirmar que o corpo deveria nos deslumbrar mais, Lacan nos chama a atenção para o paradoxo do funcionamento corporal. Isto é, o corpo não é uma evidência natural, mas resultado de articulações entre o simbólico, o imaginário e o real. Seu funcionamento

não se explica apenas por mecanismos biológicos, mas por uma estruturação que inclui a linguagem e suas incidências. O exemplo trazido é o das lágrimas, onde o choro está longe de ser apenas uma expressão afetiva, é também uma condição para seu funcionamento, revelando que o que pode parecer excesso ou desvio é na verdade estrutural. Pensando nisso, o afeto não se reduz ao sentido, mas se inscreve diretamente na materialidade do corpo.

A psicanálise lacaniana não aborda uma simples relação do corpo com o psíquico, mas traz a luz à ideia de sujeito e de gozo. Não há uma divisão entre o sujeito e o corpo, mas uma divisão no próprio sujeito, sendo o corpo pensado a partir do investimento libidinal (Garcia, 2021).

Diversas são as definições encontradas para a chamada “psicossomática”, há um pequeno limite entre processos psicológicos e fisiológicos questionado com a presença da psicanálise no real do corpo. Surge investigações de que, além de fantasias simbolizadas em uma anatomia imaginária, o corpo biológico pode servir de palco para fantasias não nomeadas e simbolizações “precárias”, isto é, forma de representação mais arcaica comparada aos neuróticos clássicos. No entanto, as diferentes correntes das escolas psicanalíticas divergem quanto à natureza específica desse fenômeno, apresentando tanto convergências quanto discordâncias entre si (Galdi e Campos, 2017). De qualquer forma, o intuito aqui é discorrer, através da teoria freudiana e lacaniana, sobre os fenômenos psicossomáticos.

Dunker (2021) critica a expressão psicossomática por reduzir o sujeito a uma ficção de unidade, isto é, a psicossomática surge como sintoma para unificar o sujeito que na verdade é dividido. Mas para ajudar a pensar nos sintomas corporais que se apresentam na clínica, o autor aponta que em cada sintoma há dois caminhos, o de intrusão e de extrusão, são duas formas de influência do significante no corpo.

Segundo Fernandes et al. (2015), considera-se o sintoma, em psicanálise, como uma metáfora passível de ser decifrada por interpretações do analista, sendo uma satisfação pulsional que assegura o ganho primário, mas que possui um núcleo inacessível. Por carregar uma mensagem, o sintoma possui um valor de verdade para o sujeito, que expressa seu desejo e seu modo de gozo. Desta forma, pode ser inserido na cadeia significante e por meio da simbolização, possibilita a redução do sofrimento

envolvido (Fernandes et al., 2015).

No fenômeno psicossomático (FPS), há algo do orgânico, uma lesão de órgão. Nestes é como se houvesse um curto-circuito na cadeia significante, recaindo sobre o corpo. A articulação do significante parece não estar em jogo, como no sintoma. Lacan (1964/2008) aborda a psicossomática como:

Algo que não é um significante, mas que, mesmo assim, só é concebível na medida em que a indução significante, no nível do sujeito, se passou de maneira que não põe em jogo a afânise do sujeito. (p. 222)

Em outras palavras, Lacan (1964/2008) parece sugerir que o FPS não pode ser interpretado da mesma forma que um sintoma neurótico. É considerado efeito da linguagem, mas o sujeito não passa pelo processo de afânise, isto é, não se dissolve na linguagem, sua marca aparece diretamente no corpo. O fenômeno, portanto, se difere do sintoma no sentido de não ser articulado da mesma forma na cadeia significante, é um acontecimento de corpo.

Embora tanto o sintoma quanto o fenômeno psicossomático envolvam o corpo e a incidência do significante, eles apresentam uma articulação diferente quando se trata de linguagem. Como já foi visto o sintoma é uma formação inconsciente que busca ser decifrado, funciona na articulação da cadeia significante onde ocorre as metáforas, o significante substitui outro e produz sentido. Já no fenômeno psicossomático, não se manifesta da mesma forma, há um curto-circuito na articulação dos significantes o que faz com que ocorra uma incidência direta do significante mestre sobre o corpo.

Agora, na clínica, como isso seria conduzido em análise? Teria uma única forma orientadora para trabalhar com os sujeitos que apresentam o fenômeno psicossomático? Longe de tentar encontrar uma resposta absoluta, já que, como foi indicado, não é na fixação que encontraremos uma resposta, se é que ela é possível. Trata então de sustentar um campo de interrogação. E é com mais dúvidas do que certezas que passo a seguir para os recortes clínicos.

Análise de vinhetas clínicas e formas de intervenção na clínica com FPS

O adoecimento psicossomático envolve uma interação complexa entre fatores externos e internos, o que torna a definição do conceito algo desafiador e sujeito a múltiplas interpretações. O rumo desta pesquisa seguiu sendo escrito de maneira a não

definir esse fenômeno, mas ressaltar a importância de escutar o sujeito que se apresenta em estado de adoecimento, onde o corpo se apresenta como palco para inscrições inconscientes.

Como metodologia, foi utilizado um levantamento teórico da literatura psicanalítica e, a partir disso, é relacionada a teoria aos recortes clínicos. O método psicanalítico baseia-se em princípios que fundamentam a prática clínica, como a escuta através da atenção flutuante (Freud, 1912), que permite ao analista não privilegiar um discurso em detrimento de outro, possibilitando assim que o inconsciente flua livremente através das formações da linguagem.

Sendo assim, este estudo visou fazer um levantamento teórico de obras psicanalíticas que abordem o tema corpo e linguagem, buscando pensar o corpo tecido pela linguagem. Para complementar o estudo e relacionar o que aparece na clínica, são apresentados recortes clínicos. Os casos aqui citados chegaram até a clínica como sendo de ordem psicossomática, nomeados assim por médicos que os encaminham. São casos que já foram encerrados, portanto não se configura em um estudo de caso.

Em psicanálise, a análise de vinhetas clínicas pode ser considerado um reajuste de elementos do discurso trazido pelo sujeito. Compreende-se que certos comportamentos e pensamentos do analisando estão de acordo com a posição discursiva em que ele se encontra (Figueiredo, 2004). É importante lembrar que o caso não é o sujeito em si, mas, como dito, é uma construção com base no que é colhido por meio do discurso. Neste, é possível pressupor sua posição subjetiva, fazendo um giro discursivo. O objetivo foi, portanto, analisar os significantes que emergiram da fala das analisantes, de modo a pensar como o corpo entra em cena como forma de transmitir aquilo que a linguagem não consegue nomear diretamente. Além disso, buscou-se considerar os efeitos da holófrase na constituição do sujeito e em seu discurso.

O significante é visto como marca material e simbólica inscrita no mundo pelos humanos, é resultado do sujeito em ato de enunciação. O sujeito dividido aponta para a articulação entre o ato e seu produto como dimensões simultaneamente conectadas e distintas, que coexistem no mesmo tempo e espaço, em camadas que se afetam mutuamente. A história, portanto, não pertence apenas ao passado: ela se atualiza no presente, manifestando-se como forma de afetação dos sujeitos pela materialidade

simbólica (Ehrlich; Dutra; Hartmann, 2023).

A utilização de vinhetas clínicas apresentadas a seguir serve para transmissão da teoria psicanalítica, assim como a transmissão do estilo de cada autor enquanto psicanalista. Nesta metodologia, não há como objetivo desenvolver um estudo generalista, mas sim contribuir na produção de estudos sobre a relação que o sujeito possui com seus sintomas e a maneira como reorienta seu gozo. Destaca-se por se constituir a partir dos impasses enfrentados na clínica, como apresentou Freud (Leitão, 2018).

Portanto, trata-se de um aparato teórico que embasa relações com a clínica e o que surge a partir dela. Com essas análises, é possível renovar a teoria de acordo com os novos impasses. Cada caso interroga a pesquisadora, essa singularidade não fala apenas do analisante, mas também da relação com a analista. Sendo assim, esta pesquisa não se reduz a uma observação, mas está em um lugar de elaboração do trabalho clínico, relacionando prática e teoria (Diniz e Pereira, 2021).

O presente estudo visou apresentar recortes clínicos, um deles foi retirado do livro “A Pele como Litoral - Fenômeno Psicossomático e Psicanálise” e outros dois exemplos são retirados da própria vivência clínica da autora desta pesquisa. Exposto isso, para a análise dos cenários apresentados, serão utilizadas obras de autores psicanalíticos como Freud e Lacan para contribuição histórica do conceito de corpo em psicanálise e também de psicanalistas contemporâneos.

Até aqui foi abordado como a psicanálise compreende os fenômenos do corpo, como a psicossomática; com os estudos é abordado sobre pulsão, já que ela está na fronteira do psíquico e somático; a visão de corpo para além do biológico, trazendo como referência o estádio do espelho na formação do Eu e o enlaçamento dos três registros lacanianos, permitindo assim aprofundar nos estudos de Lacan sobre gozo e contribuições de Authier-Revuz sobre linguagem e corpo, além de abordar as semelhanças e diferenças do sintoma e o fenômeno psicossomático.

Partindo desta base desenvolvida acima, a seguir serão analisados alguns recortes clínicos. Antes de apresentar o primeiro recorte, acrescento ainda que o corpo é sensível ao dizer, atravessado pelo Outro e com uma incrível capacidade subjetiva de lidar com o que o afeta. Cada caso apresentado aqui traz consigo um mundo subjetivo que não se

encaixa em discursos prontos. Vamos analisar cada um separadamente.

Recortes de um caso de Psoríase

Em um caso citado por Daniele Sanches, no livro *A Pele como Litoral: Fenômeno Psicossomático e Psicanálise* (2021), é abordada a Psoríase. Onde uma mulher chamada M., de 50 anos, não conseguia parar de coçar os pés, causando feridas no local. A analisante dizia não precisar de análise, mas seu médico a encaminhou. Em sua própria associação, a psoríase apareceu um ano após ter presenciado um acidente ao lado de sua casa, onde saiu de casa assustada e pisou em cacos de vidro, machucando seus pés. Nesta mesma cena, a paciente relata que poderia ter visto uma pessoa “ensanguentada”, possivelmente seu marido.

M. reafirma que a psoríase apareceu por ficar muito nervosa na ocasião, atribuindo uma função de causalidade. No entanto, ela nunca se questionou sobre a psoríase ser apenas nos pés e após um ano do acontecimento apenas. Ao não responder aos medicamentos do tratamento, foram feitos exames e contataram alergia a um componente de tinta preta, portanto, a paciente não poderia usar meias e sapatos pretos.

Sendo pouco mencionada por M. a psoríase, quando aparecia, era relatada exatamente da mesma forma e sempre com um tom inédito. Seus relatos eram marcados por uma infundável descrição de sua vida cotidiana e pela ausência de atenção de sua família com ela. Era considerada pela equipe como um sujeito distante de apropriação da sua fala, sempre focado em um membro da família. As interpretações eram tomadas como aprendizado pedagógico, sem qualquer sensibilidade a elas.

Várias sessões são ocupadas com o fato de “sangrar demais com a menstruação, de gotinha em gotinha”, ocasionando uma anemia. Este tema só cede quando seu pai é internado: “ele (o pai) tem um problema de sangrar demais pelo intestino, ele sangra de gotinha em gotinha”. Quando outro tema é introduzido, com outro membro da família como protagonista, descreve sua filha como frágil por sofrer de hemofilia: “ela sofre de um problema de sangrar demais, sangra de gotinha em gotinha”. Percebe-se que a frase “sangrar demais, sangrar de gotinha em gotinha” aparece na maioria de suas descrições sobre os familiares, como se fosse inédito.

Era raro M. trazer recordações fora de seu cotidiano, mas em uma sessão trouxe que, quando era criança, queria um sapato preto, mas devido à pouca condição financeira de seus pais, não poderiam lhe dar, pois teriam que dar para sua irmã também. Entretanto, o pai cedeu ao seu pedido e lhe comprou o sapato preto, mas não para sua irmã. Desde então, sua relação com a irmã teria mudado, assim como com sua família. Esse era o motivo, segundo M., de ninguém lhe dar atenção, novamente trazendo uma associação de causa-efeito. Ao ser questionada pela semelhança entre as falas sobre sangramentos de gotinha em gotinha, era vista uma associação precária, com respostas como “a vida é assim, né Dra., fazer o quê?” e “você está certa, todos sangram”. Percebe-se que não há espaço para uma falha, falta, sem abertura para um questionamento sobre si.

Seguindo agora com a análise deste caso, a palavra “psoríase” não apenas denota uma condição dermatológica, mas pode também carregar múltiplos significados subjetivos dependendo do contexto e da história pessoal do indivíduo. No caso de M., a palavra “sangrar” aparece repetidamente, sempre associada a um membro de sua família ou a si mesmo. Aqui, como diz Quinet (2012), percebe-se que um Eu nunca vem sozinho, está sempre acompanhado de outro.

Talvez “sangrar demais, de gotinha em gotinha”, assim como o resto de sua família, pudesse lhe dar uma sensação de pertencimento. Nos pés ensanguentados, há uma possibilidade de identificação com a irmã, não poder usar sapatos pretos. Uma forma de autopunição por ganhar os sapatos e perdido o amor de sua família.

No entanto, não há essa associação para M., o significante não se liga a outro. É sempre narrado de maneira inédita, única. Em suas narrativas de causa-efeito, não há espaço para construção simbólica, significante e significado estão colados. Os significantes “de gotinha em gotinha” ocupam um aspecto que a define, mas que poderia ter outras articulações metafóricas como: “Às vezes sangro igual meu pai” “A angústia aparece aos poucos”.

Vemos aqui a hipótese de holófrase, onde há uma fixação rígida entre um significante e seu significado, sem a possibilidade de articulação com outros significantes. Isso cria uma espécie de bloqueio na cadeia significante, prejudicando a capacidade do sujeito de estabelecer associações simbólicas mais amplas, o que não significa que não

há simbolização a ser decifrada. O significante “sangrar” parece constituir seu corpo, mas pode querer dizer “sangrar por sua família”, “perder o amor deles”, “sofrer pela falta de afeto”.

A questão principal é que o “sangrar” de “gotinha em gotinha” aparece isolado, como uma assinatura do Outro no corpo. Qual é o desejo que esse sangrar está tamponando? Sendo assim, quando a possibilidade de articular esses significantes aparece, o corpo pode deixar de ser o único local em que aquilo se escreve.

M. não falava muito sobre sua psoríase, como se fosse algo determinado, sem chance de interrogação. Sanches (2021) comenta que construir um sentido não é colocar a doença como causa, mas sim realizar a elaboração da pulsão de morte. Ou seja, quanto mais sentido, mais o sujeito se fixa em uma crença de ser representado pela lesão. Uma crença que possibilita o gozo. A partir do relato, é possível revelar qual espécie de gozo se encontra na paciente, de maneira subjetiva.

Lacan (1985) explora a ideia de que sintomas físicos podem ser uma forma de o inconsciente se expressar. Nesse sentido, a “psoríase” poderia ser vista como um sintoma, mas também como um significante dentro da cadeia de significantes que estrutura o inconsciente do sujeito.

Explicar o gozo em uma lesão de órgão não é uma tarefa fácil. A libido em pacientes ditos psicossomáticos parece não se mover, fica fixada em um órgão escolhido. De um modo específico, no fenômeno psicossomático, o Outro do significante não contorna o corpo, funciona como uma inscrição, uma sentença (Pacheco, 2021).

Recortes de um caso de Rosácea

Uma jovem de 26 anos, chamada Marina (nome fictício), chega ao atendimento procurando atendimento psicológico por indicação de seu dermatologista. Foi dito a ela que os sintomas de rosácea estavam ligados a questões emocionais, principalmente estresse. Quando questionada sobre o que ela achava disso, comentou: “Sim, sou muito estressada, não tem como mudar isso, é de mim”. Aqui temos um S1, “isso é de mim”. Queixando-se inicialmente de um “estresse interminável” e do agravamento recente de sua rosácea, que descreve como “queimaduras que aparecem do nada”, sempre nos momentos em que se sente “estressada” ou “injustiçada”. A forma como apresenta o sintoma traz uma mistura de

indignação e surpresa, como se o corpo a traísse. A analisante não associava o aparecimento dos sintomas a nenhum acontecimento.

Desde o primeiro atendimento, Marina falava bastante, sem pausa, mas suas falas eram sempre relacionadas aos outros. Trazia longas narrativas sobre colegas, familiares e amigos, mas quando era feita a tentativa de deslocá-la para si, Marina mudava de assunto ou respondia sucintamente, voltando a descrições minuciosas de eventos externos, mantendo-se fora do campo de implicação subjetiva. Quando perguntada sobre o próprio sofrimento, respondia: “Eu só fico estressada, tudo me irrita”.

Na tentativa de saber mais sobre ela, apareciam apenas relatos do cotidiano, ela quase nunca estava implicada nas cenas, o único afeto que sentia em relação aos acontecimentos era irritabilidade. Quando questionada o que a irritava, não sabia explicar, suas falas eram desconexas. As falas sobre sua mãe são marcadas pela frustração: “minha mãe é parada, não reage...”. O tom é de desprezo, misturado com mágoa. Parece esperar da mãe a firmeza que nunca encontrou.

Na relação com sua tia, parece haver uma ambivalência, ao falar sobre ela há uma intensidade oscilante. Em um momento, a descreve como sozinha, precisando de companhia, e no outro fala que ela é “controladora”, “se mete demais na minha vida”. Marina relatava também que sua tia a invejava, ao mesmo tempo não desgrudava da tia. A tia aparece como uma espécie de suporte imaginário, alguém a quem Marina recorre para validar suas percepções, mas também como uma figura que a sufoca. Essa ambivalência retorna em repetições de hostilidade e comportamentos que demonstram cumplicidade.

No decorrer das sessões, pouco comentava sobre a rosácea, salvo os dias em que os sintomas apareciam e não tinha como esconder, estava no seu rosto e em outras partes do corpo. Nesses dias, chegava estressada, dizia “hoje estou bem vermelha”, demonstrava preocupação com sua pele parecer feia, dizia sentir vergonha, ao mesmo tempo que mostrava cada parte marcada, com detalhe. Mostra o que não deveria ser visto, algo íntimo que se expõe.

Neste caso, parece não haver espaço para significantes se articularem pela via das palavras, o sintoma da rosácea pode estar operando como um significante do real do corpo, manifestando algo que não consegue ser simbolizado no discurso. Como Dunker

(2021) comenta, nos casos de somatizações, são raras as lacunas e giros discursivos.

Para análise deste caso, pego alguns significantes trazidos pela analisante, começando com “sou muito estressada, não tem como mudar isso, é de mim”. A palavra “estressada” se apresenta como algo fixo, não há articulação com uma causa ou história, “é de mim” aponta inicialmente uma impossibilidade de deslocamento, está capturada por um significante mestre sem possibilidade de movimento. Na frase “hoje estou bem vermelha”, a palavra “vermelha” articula com “ver” (olhar, visibilidade), “verme” (que corrói, parasita) “mel” (colagem, doçura, viscosidade) e “elha” (velha). Essa ambivalência se apresenta em sua relação com a tia.

Mais significantes se apresentam em “não dobra suas roupas”, “sobra para mim”, “comprou roupas de jovem”. Sobra/Dobra em ressonância sonora: aquilo que se dobra, que tem mais de uma face, interior e exterior. Roupas: podendo ser aquilo que o Outro “rouba”, seja o curso, as amizades, as roupas ou o desejo, é também aquilo que veste, cobre.

A rosácea, sintoma que aparece ligado ao estresse desde o início das sessões, aparece principalmente no rosto, local da exposição, da imagem e olhar do Outro. Nos dias em que o sintoma aparece, surge outro afeto, a vergonha, seguido por um gozo em mostrar os locais afetados, como se marcasse no corpo algo do indizível. A palavra rosácea, nesse caso, parece operar como um significante S1, que marca o impossível de dizer. Se articula com “rosa” (flor, delicadeza, amor, beleza, cor) e “ácea” (sonoramente lembra ácido, ardência). A vergonha é, como diz Mattuella (p. 67, 2015), “a certeza da posição de um corpo em sua literalidade mais fundamental, em sua dimensão mesma de estar sustentado pelo olhar do Outro.”. Ou seja, quando o sentimento de vergonha aparece, há possibilidade de acesso ao lugar de objeto que se ocupa diante do Outro. Há um movimento duplo de reconhecimento, mas também de uma tentativa de se recobrir.

O seu discurso é marcado pela oscilação entre gratidão e ressentimento, movimento que evoca a ambivalência que Freud (1915/2017) descreve como constitutiva dos vínculos afetivos, “de acordo com a experiência, a medida da ambivalência demonstrável varia consideravelmente entre os indivíduos, grupos humanos e raças” (p. 45).

A pele, além de cobrir o corpo orgânico, também fornece percepções, isto é, pode

servir tanto para proteção e sustentação como percepções de calor, dor, irritação. Por ser coberta por terminações nervosas, a mesma capta e transmite excitações. Portanto, ao tocar também somos tocados, ao afetar o mundo, também somos afetados (Anzieu, 1985/1988). E neste caso o corpo é marcado pelo que vem de fora, assim como se reconfigura através destas marcas, dando sentido a elas. Há um excesso, que não possibilita o furo, a rachadura. A busca por sentido sobre o sintoma é o que forma uma narrativa sobre seu sofrimento. Sendo o efeito do simbólico sobre o corpo. A pele, o rosto, o olhar do Outro, a vergonha, são peças de um quebra-cabeça, a ambivalência em seu discurso tenta cobrir o desejo.

Recortes de um caso de Retocolite Ulcerativa

A analisante Luiza (nome fictício), de 30 anos, chegou ao atendimento por sugestão do seu médico, pois, de acordo com ele, suas emoções estavam influenciando em seu adoecimento. Ela já havia sido internada por crise de retocolite ulcerativa e vinha apresentando medo de precisar ser internada de novo. Disse querer iniciar a análise para poder falar sem incomodar os outros sobre os mesmos assuntos. Segundo o Ministério da Saúde (2024), a retocolite ulcerativa (RCU) é uma doença inflamatória intestinal crônica, apresenta episódios recorrentes que acometem principalmente a camada mucosa do cólon. Atinge o reto e partes próximas ao cólon, geralmente de forma contínua. Os principais sintomas são diarreia frequente e com sangue, dor abdominal, perda de peso e anemia. A RCU é causada por vários fatores, sendo os principais, a alimentação, o ambiente, a genética e o sistema imunológico. Podendo ser alavancada por estresse psicológico (Assis et al., 2025).

Quando questionada sobre como foi o período da internação, começou a chorar e relatar que foi “difícil e humilhante”. Com grande restrição alimentar, ela tentava evitar ao máximo retornar a essa posição, fazendo exames recorrentes para monitorar a evolução do tratamento. Tentando explorar quais emoções poderiam estar influenciando seus sintomas, ela comentou sobre a ansiedade. Dizia estar sempre preocupada com o que vai acontecer no futuro e isso foi agravado depois da internação. Foi apresentado episódios de isolamento, tristeza e ansiedade. Estava sempre tensa com o que pode acontecer. Ao relatar sobre esses momentos em que ficava ansiosa, ela dizia: “não consigo conter”.

Os sintomas começaram logo após Luiza descobrir a traição do marido, Marcos (nome fictício). A cena descrita por ela ao encontrar mensagens escondidas a fez sentir o estômago "virar pelo avesso". Podendo ser pensada à luz do que Lacan chama de *ponto de capiton*: um momento em que os significantes que organizavam sua realidade se soltam, deixando-a sem amarração. Quando o marido a trai, o significante *marido*, que até então garantia de segurança, perde a consistência. O corpo responde onde a produção de metáforas falha. Aqui podemos pensar na ideia de holófrase, a cadeia significante se fixa de tal forma que não há intervalo, não há jogo metafórico que deslize. O corpo, então, entra como signo: um acontecimento real, que irrompe sem mediação.

Sua relação com o marido era algo que sempre aparecia nas sessões. Referente a isso, também relatava sentir medo sobre o seu futuro. Esse medo parte de um lugar de incerteza. Sobre o período em que ele foi embora, comenta: "perdi meu chão", "não esperava", "não consigo expulsar isso de dentro de mim".

Segundo a analisante, sua mãe parecia ter sido muito protetora quando ela era mais nova, sempre apresentando cuidado excessivo com sua saúde. Ela não comenta muito sobre o pai, nas vezes em que o cita diz "não se mete muito", "ele é mais contido". Sobre a mãe, o que aparece é: "ela está sempre me apoiando", "quando preciso, vou até ela", "me ajudou na internação". Em relação ao seu trabalho, comenta: "não tenho muito controle". Em seu discurso, as áreas da sua vida parecem fragilizadas, o medo emerge da possibilidade de dissolução daquilo que acredita possuir.

Para a análise, podemos ver que os sintomas não remetem a uma história, não têm um sentido além do que enunciado pelo médico: "suas emoções têm afetado o seu adoecimento" e, quando tenta nomear essa emoção, diz ser ansiedade, preocupação.

Há algo que não pode controlar, mas a analisante mesmo assim tenta, através de exames frequentes, busca por sinais se o marido irá a deixar novamente, entre outras preocupações. Sem deixar espaço para a falta, tenta preencher todas as lacunas dos discursos a sua volta.

Em suas palavras, ou não, a mãe sempre esteve presente (S1), o pai era "mais na dele", quieto e sem muita participação, ocasionando um enfraquecimento da função paterna. A lógica da "falha" na metáfora paterna que remete a colagem dos significantes primordiais, implica também dizer que houve uma interrupção na fase da castração que

impede a emergência do objeto a (Nicolau, 2008). Isto é, não havendo separação, não há espaço para falta, assim como em seu discurso.

A separação no caso apresentado não é suportada, “perdi meu chão” e de fato parece perder, necessitando ser carregada pela mãe, apoia-se nela. Perdeu seu suporte, sua suposta referência. Há marcas que escapam do domínio da palavra, restos que não foram escritos e que estão ligados a um Real. O sintoma, nesse caso, não consegue ser interpretado, está alheio ao sujeito. Embora esse fenômeno remeta a um gozo indecifrável, ainda está ligado a significantes primordiais. O sintoma neste caso se ancora no corpo, como espaço de Outro, e esse Outro é também lugar do significante. No seminário 20, Lacan (1975) introduz a noção de lalíngua, é da lalíngua que se retira o significante que representa o sujeito para outro significante. A frase “não consigo conter” dita em uma sessão simbolizou para mim os seus sintomas, mas não conseguiu criar metáforas a partir disto, escapou direto para o corpo quando não conseguira conter suas fezes. Essa fala aponta talvez uma invasão de excessos de sentido no qual não consegue dar borda pela fala. Neste ponto, o corpo e o discurso estão implicados. Não consegue conter as fezes, mas muito mais do que isso, não consegue conter o marido, o desejo, a vida. A frase que ecoa tanto a função intestinal quanto sua relação com o Outro.

“Às vezes não dava tempo”, representando uma urgência, mas urgência em relação ao quê? Garcia (2021) traz justamente que a noção de intervalo entre significantes é o que pode trazer a indagação sobre seu próprio desejo, além daquilo que está inscrito no Outro. Com a holófrase, é como se o significante fixasse no corpo sem possibilidade de deslizar.

A hipótese de haver uma holófrase local, Assadi (2021) compreende que isto não quer dizer a ausência de desejo, a forclusão, mas que os significantes estariam congelados, o desejo estaria suspenso. Como, por exemplo, as expressões usadas pelas analisantes M. e Luiza, “não consigo conter” e “de gotinha em gotinha”, que apresentam a ausência de metáfora, o significante (S1) ocupa o lugar do significado.

Percebe-se no caso que a analisante não encontra recursos metafóricos suficientes para nomear sua dor, sua angústia ou falta. A possibilidade do marido a deixá-la por outra novamente aparece como traumática, “não consegue conter” o marido de sair da sua vida. O excesso de sentido, do Outro, acaba por não encontrar saída por meio da fala, mas

descarrega no corpo. Além disso, Luiza inicialmente comenta que não havia espaço para abordar seus pensamentos e sentimentos, não queria preocupar a mãe e o marido parecia não se importar, limitando o espaço de enunciação pessoal.

A imaginarização aponta um afastamento do sujeito do campo simbólico, apontando uma retração de sua participação no laço social (Bacelar e Coutinho, 2022), mas vale lembrar que não é falta de simbolização, pois como já dito anteriormente, o sujeito nasce dentro do simbólico. O que quero dizer é que, em algum momento da vida, o significante a invadiu sem poder recorrer a outros mecanismos que não um órgão físico. É um excesso que não consegue ser metabolizado, isto é, articulado em uma cadeia significante. Freud (1915/2017) já apontava nos textos sobre neurose de angústia e depois nos fenômenos conversivos que há um ponto onde o estímulo se torna traumático e precisa ser descarregado no corpo.

Os discursos podem oferecer uma maneira de se relacionar com o Outro que não se reduz ao gozo, a imaginarização vai pelo caminho inverso, pois, limita a abertura do sujeito à alteridade. Ao não dar espaço para o Outro, o sujeito pode cair em um estado de submissão ao gozo, pois recusa a falta do Outro (Bacelar e Coutinho, 2022). Isso pode significar retornar ao desamparo primordial, semelhante ao vivido na infância, onde o sujeito não tinha palavras ou símbolos para lidar com a experiência, apenas o corpo.

A retocolite ulcerativa, em sua dimensão psicossomática, neste caso revela um corpo que faz palco de uma resposta à invasão do Outro. O intestino inflamado, sangrante, “em crise”, aparece como o real literal de uma borda violada. A mucosa ulcerativa diz algo sobre limites, ou a falta deles. Ao analisar a materialidade significativa das palavras “retocolite ulcerativa”, podemos ver que seu peso não reside apenas em um diagnóstico médico. O “reto” se liga diretamente ao intestino, evacuação, àquilo que precisa ser eliminado. No registro simbólico, se articula a borda, limite entre dentro e fora. Já “colite” deriva de cólon, que, acrescentada ao sufixo –ite, indica inflamação, diz de um excesso. O termo “ulcerativa” vem de úlcera, uma ferida aberta que causa ruptura com a superfície. Quando unidos, os termos reto-cólon-úlcera acabam por desenhar uma topografia do corpo que fala de uma falha na contenção, de um limite. A materialidade das palavras remete a um corpo que não consegue “conter”.

Assim, “a que se prendem os sintomas? – senão à implicação do organismo

humano em alguma coisa que é estruturada como uma linguagem, com o que tal elemento de seu funcionamento vai entrar em jogo como significante” (Lacan, 1956/1988, pg 217). Isto é, os sintomas se vinculam a um organismo que é desde sempre implicado pela estrutura da linguagem. Não é puramente biológico, o corpo é atravessado pelo simbólico, não se reduzindo a um efeito puramente orgânico ou psicológico, mas é efeito da captura do corpo pela linguagem.

Resultados

Se algo é sugerido pelas reações psicossomáticas como tais, é justamente por elas estarem fora do âmbito das construções neuróticas. Não se trata de uma relação ao objeto. Trata-se de uma relação a algo que está sempre no limite de nossas elaborações conceituais, em que se pensa sempre, de que se fala por vezes, e que propriamente falando não podemos apreender e que, no entanto, está aí, não se esqueçam disto - estou-lhes falando do simbólico, do imaginário, mas há também o real. As relações psicossomáticas estão no nível do real. (Lacan, 1978/1987, p. 127).

Quinet (2016) retoma que Lacan já advertia que não há viabilidade de acessar o real por meio da representação, já que o sintoma vem do real e não se deixa capturar pelo sentido. Quando o sintoma é frequentemente investido de significados e sentidos, acaba por alimentar o gozo. Isso quer dizer que quanto mais interpretado em termos de sentido, mais consistência imaginária o sintoma adquire. Isto aparece nos casos citados, as analisantes chegam com uma certeza sobre seu adoecimento, respectivamente a cada caso, existe a certeza sobre a influência de que não precisa de análise, de que a rosácea é ocasionada pelo estresse e que a retocolite é influenciada pela ansiedade.

Embora possa existir uma tendência de criar categorias que busquem “facilitar” o manejo clínico ou unificar os sintomas de acordo com um conceito específico, isso acaba por não ser tão simples e nem desejado para nós psicanalistas, pois corre o risco de irmos para o mesmo caminho da nosografia psiquiátrica. O que se busca aqui é considerar a pluralidade das produções do sujeito (Branco; Abeche; Pinheiro, 2021).

Nestes casos é apresentado um modo que difere da clínica centrada no Nome-do-pai e da interpretação, para centrar no falasser, e na dinâmica entre fala e corpo (Oliveira, 2021). É o que vemos nos casos apresentados, pois diferem de uma clínica baseada na interpretação, não é sobre dar um sentido aos seus sintomas, mas trabalhar com o que é

intraduzível. Por mais que fossem feitas interpretações como: “Nos pés ensanguentados, há uma possibilidade de identificação com a irmã, não poder usar sapatos pretos.”; no caso de Luiza quando diz perder o chão é interpretado que “Perdeu seu suporte, sua suposta referência”. Mas não parece fazer efeito.

Quando Quinet (2009) fala sobre o falasser é um ser que fala e goza a partir de seu inconsciente por meio do sintoma, o autor vai reformular o conceito de sujeito em Lacan. Trata-se de um corpo falante, atravessado pela linguagem e afetado por ela na lógica do gozo. O inconsciente não fica apenas como algo a ser interpretado na busca de sentido, mas é algo que o sujeito goza de uma maneira particular e é o que o sustenta através do sintoma. Pela linguagem ser falha justamente por ser linguagem, ela não recobre o corpo de maneira harmônica, ela introduz falhas e excessos. Diante desta fratura, é que o sujeito precisa encontrar um modo de se sustentar, uma amarração possível entre a fala e o que goza no corpo.

A clínica do nó borromeano destaca justamente as soluções singulares de cada sujeito. Quando pensamos no registro do Real, Imaginário e Simbólico como anéis que se articulam e se mantêm unidos sem sobrepor um ao outro, Lacan abre espaço para pensar formas não normativas de amarração. Sendo assim, não significaria entrar em um esquema clássico de neurose e nem cair na desamarração psicótica, mas diz de criar um modo próprio de manter esses registros enodados (Oliveira, 2021).

O corpo no fenômeno psicossomático é a principal referência de sofrimento psíquico, que muitas vezes já vem nomeada por um saber médico, assim como nos casos apresentados. Essa lesão retratada pelo analisante passa a ser central em sua vida, funciona como um ponto de fixação que organiza os pensamentos, suas angústias e a forma de viver. O sujeito é capturado por esse gozo, que é invasivo, dificultando a produção de significantes. Desta forma, a função da clínica analítica seria, nestes casos, possibilitar a restituição do significante que ficou fixado e assim reinscrevê-lo no circuito da linguagem, fazendo borda para o sujeito e o que o atravessa (Nicolau, 2008).

Com o nó borromeano, é possível pensar que compreender o gozo coloca o corpo como suporte fundamental do discurso analítico, é uma clínica que fica orientada nos nós. Prova-se assim uma passagem do Um, aquele fixo que já foi comentado antes, para uma dinâmica de associação e dissociação, um movimento que tente abrir espaço da escrita

que inicialmente é ilegível e possa ir, pelo menos em parte, para a ordem da fala (Nicolau, 2008).

Assim sendo, a intervenção analítica destes casos não se orienta pela interpretação ou produção de novos sentidos, mas na redução do excesso que se apresenta. Essa redução do gozo pode acontecer por meio do giro discursivo, tentar deslocar o sujeito do saber que o define. O analista vai intervir na holófrase, fragmentando-a e possibilitando que o sujeito possa construir significados. Não visa apenas sumir com os sintomas, mas fazer com que o sujeito encontre formas de ressignificar sua relação com o desejo, com o Outro e com o corpo (Cabral, 2024). Para além disso, o analista deve se apropriar de outros lugares que não seja o do suposto saber, para tentar dar borda ao que transborda nos sintomas. É preciso que, em alguns casos, o analista empreste seu próprio corpo para conter o gozo do analisante, fazendo surgir o inconsciente (Oliveira e Winter, 2019). Isto é, o corpo do analista aparece com sua presença, sua voz, seu olhar não invasivo, um corpo sustentado pela ética da psicanálise.

Desta forma, o corpo falante que, como vimos, é o corpo atravessado pela linguagem e gozo, é sede da Alíngua que se corporifica através do sintoma. Este, por sua vez, é uma resposta do sujeito aos efeitos da linguagem sobre o corpo, possibilita sustentar sua existência com o real. Em análise, é possível que o sujeito consiga saber-fazer com ele, através do reconhecimento da sua própria forma de se enlaçar ao Outro e habitar seu corpo (Quinet, 2009).

A identificação com o sintoma vai tratar de uma identificação paradoxal, já que não é um traço identificatório simbólico, mas um modo singular de gozo, é o que resta do efeito de um percurso analítico. Nesse sentido, a identificação vai dizer de assumir o sintoma não mais como uma mensagem a ser cifrada e sim como letra, como uma marca da lalíngua. Com isso, no final da análise, o sintoma deixa de operar como portador do sentido e passa a ser visto como o real que se inscreve no corpo e na fala sem ter tradução. Isso pode possibilitar uma relação mais direta e menos sofrida com o que não cede à interpretação. Assim, talvez seja possível manter uma certa distância do sintoma para poder manejá-lo sem ser subjugado a ele (Quinet, 2016).

Relacionando isso aos casos apresentados, pode-se ver a rosácea como uma forma de se enlaçar ao Outro, não tem uma tradução, mas é uma forma de existir diante do Real que se atravessa. Com a análise, o sujeito passa a reconhecer o sintoma como sua forma de existir no mundo e sua exigência de corresponder ao olhar alheio. Assim como no caso de retocolite ulcerativa, onde a analisante sofre com inflamação no intestino, órgão ligado à eliminação do resto, evidencia de maneira clara a incidência do real no corpo. Ao longo da análise, o processo não consiste em interpretar o sintoma, mas possibilitar que a analisante reconheça sua forma particular de relação com a angústia. O sintoma deixaria de ser apenas uma ameaça e passaria a ser algo com o qual ela poderia estabelecer um certo manejo.

No caso de psoríase, a analisante chega à análise não para pedir uma solução, mas uma forma de manejo de enfrentar sua forma singular de vivenciar aquilo que a afeta, a angústia, a dor familiar, a rejeição. A analisante, durante o processo de análise, aprende a ver o sintoma como uma forma de enlaçar o Outro e o real. A partir da fala das analisantes é que pode-se perceber a posição discursiva que cada uma ocupa diante de seu sintoma, portanto o foco da análise não seria traduzir o sintoma, mas permitir que a pessoa afetada possa, através da fala fazer uma transliteração de sua marca, da escrita em seu corpo.

A noção de discurso em Lacan (1969-1970/1992), possibilitou mostrar como o sujeito é enlaçado ao campo do Outro. O corpo não é apenas portador de marcas individuais, mas contém marcas de discursos que estruturam o sujeito e regulam seu modo de ser e estar no mundo. Com isso, pensam-se em diferentes formas de gozo que o sujeito encontra para poder existir. O que nos leva à segunda questão e principal: de que maneira a linguagem se inscreve no corpo ao ponto de afetar os sintomas psicossomáticos?

Através das vinhetas clínicas trazidas na pesquisa, foi visto que há uma forma de gozo que diz de um excesso inassimilável. Nos casos há um excesso de sentido, que não possibilita abertura, questionamento. Há uma certeza sobre suas dores e suas relações, mas que no fundo tampona algo do Real, do intraduzível. Significantes que aparecem demonstrando um significado único acabam por não deslizar na cadeia significante.

O que aparece com a pesquisa é que, nestes casos, houve um curto-circuito na cadeia significante, que acaba por dar um significado fixo a determinado momento, à

concepção de si ou dos seus sintomas. A hipótese da holófrase foi levantada justamente por aparecer, em determinados momentos dos discursos das analisantes, o significante colado ao significado.

Nesta perspectiva, a libido parece não se mover, fica fixada em um órgão como uma marca que continua a fazer efeito, pois está imersa na linguagem. Como por exemplo a frase “sou estressada, é de mim” dita pela analisante Marina, seu discurso aparece fixado em um determinado aspecto, esse enunciado funciona como uma identidade que a própria analisante toma como sua essência, impedindo uma articulação significativa. Outros significantes poderiam surgir, como “sou estressada, porque minha tia me estressa”, “porque não consigo me estabelecer profissionalmente”, “porque nego o meu desejo”. A rosácea aparece sinalizando o estresse não articulado na cadeia significativa, se inscreve no corpo de maneira direta, sendo a pele um ponto de fixação. Quando Marina evidencia que “queimaduras que aparecem do nada” mostra que o corpo irrompe sem aviso, a surpreende como se fosse estranho a ela.

A vergonha esconde algo se perceber como objeto do Outro, olhada, vista. Também nota-se a ambivalência em sua relação com a tia e a repetição do discurso referente a ela. Uma forma de gozo. A frase “minha pele pega cor rápido, fica bonita” contempla dois significantes importantes de se analisar: pele e cor, um dando valor ao outro, quando a pele pega cor é que a beleza surge. Cor vermelha? Quando diz “hoje estou bem vermelha” ou rosa? De rosácea. É uma marca, um significante que aparece diretamente no corpo, na pele.

O significante “estressada” repetido várias vezes parece nomear tudo, mas nada explica. Trata-se de um S1 que não se articula a outros S2, impede que seja construída uma narrativa subjetiva. Neste caso, o sintoma psicossomático pode ser válido como efeito de holófrase, não havendo possibilidade de produção de metáforas. Seguindo esta lógica, o significante solidifica-se na carne, faz com que o corpo deixe de ser um lugar de representação simbólica e torne-se o suporte direto do gozo do Outro. Este é entendido como gozo absoluto que não foi mediado pela castração fálica. O gozo não-fálico se manifesta de maneira ilimitada e invasiva, agride a economia libidinal e se manifesta como lesão.

Percebe-se que, onde deveria haver uma separação, o que permitiria a inscrição da falta e da perda, há uma recusa da falta do Outro. Não se trata de uma escolha consciente, mas de um modo de defesa, onde o sujeito evita sofrer com a castração simbólica, como por exemplo a falta do Outro, como quando há a separação no caso de Luiza, há a negação de que não existe uma garantia total sobre seu relacionamento, o Outro não é completo e nem ela pode ser tudo para esse Outro. Com isso, o que poderia estar no plano da fala e da articulação significante acaba se deslocando para o corpo. Neste ponto, que entra a hipótese de holófrase, pois não há deslizamento do sentido. Tudo é condensado de uma forma fechada, única e impede a emergência do sujeito dividido. A consequência é o corpo responder pelo organismo e não pela palavra (Dimitriadis, 2016).

No caso de M., que apresentava psoríase, verificaram-se significantes que se repetem e que causam efeito também em seu corpo, como “sangrar demais, de gotinha em gotinha”, não há articulação para que metáforas possam surgir. Como se fosse da ordem do número, uma iteração. Lacan (1975/1985) aponta que a iteração é a repetição do mesmo, um mesmo que não produz diferença. O número marca a presença de unidade, assemelhando-se à contagem matemática. Pensando que o número se sustenta sozinho e se repete sempre do mesmo jeito, o sintoma da psoríase neste caso também. Aparece sempre no mesmo local e sustentado sempre pela mesma narrativa. Neste caso, o sintoma não é passível de interpretação, mas aparece como uma escrita real no corpo. É uma escrita que produz sentido rígido, permanece fixada como uma marca.

Com Luiza, percebe-se que os sintomas não remetem a uma história, não há construção de novos sentidos, se reduzem apenas à ansiedade. “Sou ansiosa”, “perdi meu chão”, “estômago vira do avesso”, “não consigo conter”. Todas estas frases remetem a uma angústia, mas que não encontra outro caminho de descarga além do corpo. Mostrando que há marcas que se apresentam condensadas em holófrase, as quais precisamos abrir na clínica.

Percebe-se que a analisante vê a possibilidade de o marido deixá-la por outra novamente como traumática, “não consegue conter” o marido de sair da sua vida. Sua dificuldade de simbolizar a separação reaparece no corpo. O corpo fala a partir do que foi inscrito nele através da linguagem, acontece no corpo o efeito de discursos que atravessam o sujeito e que, por não encontrar enunciação simbólica, emerge como marca real no corpo.

Aqui poderíamos dizer que o significante “não conter” aglutinaria vários significantes, como “não consigo conter meu marido”, “não consigo conter as fezes”, “não consigo conter a minha tristeza”. Assim como a “água” para a criança pode conter uma frase inteira, “mamãe, quero água”. Essa fala aponta talvez algo da impossibilidade de dar borda pela fala. Neste ponto, o corpo e o discurso estão implicados. Aqui apresenta-se um exemplo de holófrase, quando uma expressão pode aglutinar uma frase inteira, mas é como se fixasse em um significado apenas.

A relação da analisante com as figuras parentais, onde a presença materna aparece marcada pelo excesso de cuidado e a função paterna se configura pouco operante, reforça a fragilização da inscrição da falta, favorecendo uma posição subjetiva de dependência e recusa da perda/falta. Neste contexto, a separação do marido atualizou algo do desamparo primordial, passando a responder com o corpo. Desta forma, percebemos que o corpo capturado pela linguagem apresenta seus efeitos de maneiras diversas. Com a limitação de produção metafórica, o sujeito fica fixado em um signo, em uma marca que o constitui. Quando fixado em um discurso, acaba por não dar abertura à alteridade, recusando também a falta do Outro.

É nesta linha de pensamento que a clínica do nó borromeano pode entrar, destacando as condições singulares de cada sujeito. Ao trabalhar com os três registros Imaginário, Real e Simbólico, podemos articular também novas formas de amarração, não entrando apenas em um esquema clássico de neurose ou psicose, mas de possibilitar criar uma maneira própria de manter estes registros enlaçados (Oliveira, 2021). Sendo assim, podemos trabalhar com o inconsciente não apenas buscando interpretação, mas ver quais as formas de articulação que o sujeito pode encontrar através de como o inconsciente se apresenta para se sustentar no mundo.

Vimos que a linguagem é falha e não recobre harmonicamente o corpo, causa efeitos diversos. Nos casos apresentados, vimos que o sintoma, seja ele psoríase, retocolite ulcerativa ou rosácea, está atrelado a algo do impossível de decifrar, é um traço que se repete, há uma fixação do número. Onde o discurso das analisantes é da ordem do sentido, o corpo mostra algo do real. Isso demonstra o quão enodados estão os três registros e que não é possível pensar em uma supremacia de um sobre o outro, mas uma forma específica de gozo (Chaves, 2009).

A proposta seria, ao longo da análise, possibilitar que a escrita possa ser lida por alguém, como uma carta (Alves, Brandão e Chatelard, 2019). É esse o papel do analista. O endereçamento ao Outro passa a ser necessário para poder ocorrer uma releitura da própria escrita. Portanto, o trabalho analítico seria possibilitar a criação no um a um com cada analisante. Ofertar uma possibilidade de dar lugar ao corpo pulsional do sujeito, onde a analisante possa fazer de uma marca, um enigma. Isto a partir do endereçamento ao analista. Assim, o sujeito pode se deslocar em seu discurso, sem ficar fixo em apenas um sentido.

O sofrimento imposto ao sujeito pelo corpo que apresenta sintomas psicossomáticos convoca a psicanálise a produzir vias possíveis de escuta e tratamento. Ainda que a psicanálise não trate com a promessa de cura dos sintomas, o que ocasionaria um obstáculo na escuta do sujeito do desejo, ela pode operar efeitos terapêuticos na medida em que trata o real, aquilo que não cessa de não se escrever. Estes efeitos irão surgir a partir do percurso da experiência analítica, na transferência, quando um saber que é inédito pode advir.

Quando nos afastamos de ideais normativos de saúde e bem-estar, podemos possibilitar a escuta daquilo que a escrita muda do corpo e expressa por meio da dor ou afecções orgânicas. Mesmo que não seja possível uma interpretação, pode ocorrer a transliteração, ou seja, passagem de uma escrita para outra, diferindo do que ocorre com tratamentos exclusivamente medicamentosos, que silenciam o sintoma sem propor um lugar de inscrição simbólica (Ventura, 2013).

Em suma, o manejo da transferência seria por meio da transliteração, como foi abordado anteriormente, assim possibilita acesso ao inconsciente a partir daquilo que se inscreve no corpo. Com tudo, que foi abordado até aqui, este estudo permitiu conceber que o fenômeno psicossomático não parece ser um déficit de simbolização, já que o corpo é constituído por este. O que acontece é que, no discurso, o sujeito fica preso em significantes rígidos, acontece então uma falha na articulação da cadeia significante. O que o analista faz é propor outros significantes, desfazendo a holófrase, abrindo para outras articulações do significante que está fixado em um sentido.

A transliteração entraria como uma forma de produzir significantes que possam criar uma condição onde a analisante não é conduzida à tradução de seu sintoma, mas na sustentação do significante em sua materialidade. Nesta perspectiva, retomo a expressão cristalizada como “sangrar demais de gotinha em gotinha”, neste caso a intervenção não visaria explicá-la, mas trabalhar em cima dos elementos como “sangra” e “gota”, fazendo surgir outros efeitos de escrita e não o fechamento de sentido.

Com isso, cabe ao analista sustentar uma direção de tratamento de modo a acolher o sofrimento de um corpo que padece, criando uma continência para a angústia e um campo simbólico capaz de dar borda ao real, assim o corpo pulsional do analisante pode emergir no discurso. A transferência entraria aqui como grande aliada para o suporte simbólico necessário que o analista pode representar. Possibilitando um giro discursivo e a abertura para novas narrativas que deem borda ao real, ou até mesmo faça com que a iteração passe para transliteração. Para que, a partir disto, a analisante possa construir outras formas de amarração dos três registros: Real, Imaginário e Simbólico. Trata-se de permitir uma invenção singular.

Desta forma, mesmo que o analisante enuncie um discurso cheio de sentido, ou até mesmo fique impedido de articular significantes por conta de uma fixação, cabe ao analista, na particularidade de cada caso, analisar a função que o sintoma ocupa para a economia libidinal de quem o endereça à fala.

Por fim...

Acredito ser importante ressaltar que o estudo não visa indicar a psique como causadora de doenças orgânicas, mas apontar os efeitos da linguagem no corpo, com recortes clínicos sobre os fenômenos psicossomáticos e a hipótese de holófrase nestes casos. Sem generalizar sintomas ou funcionamentos, compreende-se que cada sujeito encontra um jeito de lidar com sua angústia, com cenas traumáticas e que, por vezes, através do sintoma, isto se expressa de maneira singular.

Estes fenômenos psicossomáticos estão sendo vistos aqui como uma forma de gozo, isto é, da ordem do excesso que muitas vezes é insuportável para o sujeito e não assimilável. Como dito anteriormente, o significante pode fazer borda ao excesso de gozo.

No entanto, nestes casos, por não haver intervalo e articulação, há justamente o excesso de gozo como produção de sentido. Um sentido fixo, que impede a abertura para o sujeito surgir e desejar.

Como foi visto, nos fenômenos psicossomáticos, o analisante sofre de outro modo. Nos casos apresentados, o significante pode não se ligar a outro, fica congelado. Foi através dos recortes clínicos que pode ser analisado a possibilidade de ocorrer a holófrase nestes fenômenos. Sendo assim, a dissertação buscou sustentar uma leitura do corpo através dos recortes de casos clínicos, dando ênfase ao fato de que o corpo, para além do biológico, é um lugar de inscrição do inconsciente e incidência do gozo. No decorrer do percurso teórico e clínico que foi apresentado, o corpo se mostrou não um mero pedaço de carne, mas um campo atravessado por discursos que produzem marcas singulares, traços unários. Com a orientação lacaniana diante destes casos, exige-se uma escuta do que é enunciado pelo analisante, para poder ser captado as formações que apresentam excesso de sentido e que se manifestam através de sintomas.

Com a noção de holófrase, procurei destacar que, em determinados casos, o encadeamento significativo não desliza, convocando o corpo a ser um lugar de suplência. Nestes casos, os sintomas não foram passíveis de interpretação, mas de mostrar inscrições fixas que se expressam no corpo.

Dessa forma, o que busco é uma clínica que não normatize o sujeito e nem que apague suas marcas, pois são elas que o constituem. Além acompanhar a construção de soluções singulares que possam fazer enlaçamento entre o corpo, linguagem e gozo. É algo que opera uma invenção ou estabilização onde permite ao falasser buscar um próprio modo de existir no seu corpo e de criar laços.

Conclui-se que se constitui na relação entre corpo e linguagem, e que essa constituição não é imediata, mas construída ao longo das relações com o Outro. O sentimento de existir um “corpo próprio” e uma identidade depende da imagem especular mediada pela linguagem e pelo olhar do Outro. Sendo assim, o corpo e a fala não são totalmente próprios, resultam da interação com o campo simbólico. O sujeito, enquanto falasser, é marcado pelos efeitos dos significantes e como eles se articulam, produzindo formas singulares de sentir, desejar e gozar. Ou seja, o corpo é profundamente atravessado e estruturado pela linguagem.

REFERÊNCIAS

- ALVES, Rafaela Brandão; AMPARO, Deise Matos; CHATELARD, Daniela Scheinkman. Psicossomática: um fenômeno entre o saber e o gozo. *Arquivos Brasileiros de Psicologia*, Rio de Janeiro, v. 71, n. 1, jan./abr. 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.36482/1809-5267.ARBP2019v71i1p.174-183>.
- ANZIEU, Didier. *O eu-pele*. São Paulo: Casa do Psicólogo, 1988.
- ASKOFARÉ, Sidi. Considerações sobre o corpo em sua relação com a estrutura e os discursos. In: _____. *O corpo no discurso psicanalítico*. 1. ed. Curitiba: Appris, 2019.
- ASSADI, Tatiana Carvalho. a-pele. In: DUNKER, Christian et al. *A pele como litoral: fenômeno psicossomático e psicanálise*. 2. ed. São Paulo: Zagodoni, 2021.
- ASSIS, G. C. S. de et al. Retocolite ulcerativa: revisão narrativa sobre aspectos clínicos, terapêuticos e qualidade de vida. *Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences*, v. 7, n. 7, p. 506–530, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.36557/2674-8169.2025v7n7p506-530>.
- AUTHIER-REVUZ, Jacqueline. *Le dehors du langage au dedans du dire: la question de la parole propre*. Berlin/Boston: Dörlemann Satz, 2020.
- AURÉLIO. *Dicionário Aurélio Online*. Disponível em: <https://dicionarioaurelio.com>. Acesso em: 25 nov. 2025.
- BACELAR, Joyce; COUTINHO, Denise. A noção lacaniana de imaginarização: a clínica psicanalítica e seus desdobramentos no social. *Revista Latinoamericana de Psicopatologia Fundamental*, São Paulo, v. 25, n. 1, p. 83-105, mar. 2022. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/1415-4714.2022v25n1p83.5>.
- BARROSO, Adriane. Lacan: entre linguagem e pulsão, por uma psicanálise do sujeito. *Revista Subjetividades*, Fortaleza, v. 15, n. 1, abr. 2015.
- BIRMAN, Joel. Corpos e formas de subjetivação em psicanálise. *Estados Gerais da Psicanálise*, Segundo Encontro Mundial, Rio de Janeiro, 2003.
- BITELMAN, B. Psicossomática em gastroenterologia. In: VOLICH, R. M.; FERRAZ, F. C. (orgs.). *Psicossoma: Psicanálise e psicossomática*. São Paulo: Casa do Psicólogo, 1997. p. 171-76.
- BOCCA, Francisco Verardi. Histeria: primeiras formulações teóricas de Freud. *Psicologia USP*, São Paulo, v. 22, n. 4, p. 879-906, 2011.
- BRANCO, Daniel Ribeiro; ABEICHE, Regina Perez Christofolli; PINHEIRO, Débora Patrícia Nemer. Sintoma e fenômeno psicossomático: relações possíveis para a psicanálise. *Psicologia em Revista*, Belo Horizonte, v. 27, n. 2, p. 386-403, ago. 2021.

Disponível em: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1677-11682021000200386. Acesso em: 05 dez. 2025.

BREUER, J.; FREUD, S (1893-1895). Sobre o mecanismo psíquico dos fenômenos histéricos: comunicação preliminar. In: *Edição standart brasileira das obras psicológicas completas de Sigmund Freud*. V. II, Rio de Janeiro: Imago, 1996.

BRUDER, Maria Cristina Ricotta; BRAUER, Jussara Falek. A constituição do sujeito na psicanálise lacaniana: impasses na separação. *Psicologia em Estudo*, v. 12, n. 3, dez. 2007. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1413-73722007000300008>.

CABRAL, Selma Carneiro Pirani. *O fenômeno psicossomático como marca do real*. Curitiba: PUCPR, 2024.

CATANI, Júlia. Histeria, transtornos somatoformes e sintomas somáticos. *Jornal de Psicanálise*, São Paulo, v. 47, n. 86, jun. 2014.

CHAVES, Wilson Camilo. Considerações a respeito do conceito de real em Lacan. *Psicologia em Estudo*, v. 14, n. 1, mar. 2009.

COSTA, G; ALVAREZ, L. O silêncio da alma. In: COSTA; G. *A clínica psicanalítica das psicopatologias contemporâneas*. 2ª Ed. Artmed. 2015. p. 140-163.

CUKIERT, Michele; PRISZKULNIK, Léia. Considerações sobre eu e o corpo em Lacan. *Estudos de Psicologia*, Natal, v. 7, n. 1, jan. 2002.

DIMITRIADIS, Yorgos. Pesquisa psicanalítica sobre os fenômenos psicossomáticos. *Ágora*, Rio de Janeiro, v. 19, n. 1, jan./abr. 2016.

DINIZ, Margareth; PEREIRA, Marcelo R. A presença da psicanálise na universidade. *Revista da FAEEBA*, Salvador, v. 29, n. 60, out./dez. 2020.

DUNKER, Christian. Psicanálise e contemporaneidade. *Stylus*, Rio de Janeiro, n. 33, p. 119-137, 2016.

DUNKER, Christian; RAMIREZ, Heloísa H. A.; ASSADI, Tatiana C. *A pele como litoral: fenômeno psicossomático e psicanálise*. 2. ed. São Paulo: Zagodoni, 2021.

FERRAZ, F. Das neuroses atuais à psicossomática. In: VOLICH R. M., FERRAZ, F.C. e ARANTES, M.A.A.C. (orgs.) *Psicossoma II - Psicossomática Psicanalítica*. São Paulo, Casa do Psicólogo, 1998. p. 121-136.

FERNANDES, Carla et al. Corpo e fenômeno psicossomático na clínica psicanalítica. *Psicologia em Revista*, Belo Horizonte, v. 21, n. 3, set. 2015.

FERREIRA, Nadiá. Jacques Lacan: apropriação e subversão da linguística. *Ágora*, Rio de Janeiro, v. 5, n. 1, 2002.

FIGUEIREDO, A. C. A construção do caso clínico. *Revista Latinoamericana de Psicopatologia Fundamental*, v. 7, n. 1, p. 75-86, 2004.

FREUD, Sigmund. *A etiologia da histeria*. Rio de Janeiro: Imago, 1969.

FREUD, Sigmund; BREUER, Josef. *Estudos sobre a histeria*. São Paulo: Companhia das Letras, 2016.

FREUD, Sigmund. Projeto para uma psicologia científica. In: _____. *Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas*. Rio de Janeiro: Imago, 1996.

FREUD, Sigmund. Além do princípio do prazer. In: _____. *Obras completas*. Rio de Janeiro: Imago, 1920.

FREUD, Sigmund. *O mal-estar na civilização*. Rio de Janeiro: Imago, 1996.

GALDI, Maíra Bittar; CAMPOS, Érico Bruno Viana. Modelos teóricos em psicossomática psicanalítica: uma revisão. *Temas psicol.* Ribeirão Preto, v. 25, n. 1, p. 29-40, mar. 2017. Disponível em: <http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-389X2017000100003>.

GARCIA, Joseane. *O fenômeno psicossomático e o objeto a*. Curitiba: Appris, 2021.

GUTIÉRREZ-TERRAZAS, José. O conceito de pulsão de morte. *Ágora*, Rio de Janeiro, v. 5, n. 1, 2002.

HARTMANN, Fernando. *Retorno à caverna de Platão*. São Paulo: Zagodoni, 2023.

IMANISHI, Helena. A metáfora na teoria lacaniana. *Boletim de Psicologia*, São Paulo, v. 58, n. 129, 2008.

KATZ, Gildo; COSTA Gley P. *Psicanálise das manifestações psicossomáticas*. 1. Ed. Porto Alegre: Buqui, 2021.

LACAN, Jacques. *O seminário, livro 1: os escritos técnicos de Freud (1953–1954)*. 3. ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1986.

LACAN, Jacques. *O seminário, livro 2: o eu na teoria de Freud e na técnica da psicanálise (1954–1955)*. 2. ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1987.

LACAN, Jacques. *O seminário, livro 3: as psicoses (1955–1956)*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1988.

LACAN, Jacques. *O seminário, livro 4: a relação de objeto (1956–1957)*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1995.

LACAN, Jacques. *O seminário, livro 5: as formações do inconsciente (1957–1958)*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1999.

LACAN, Jacques. *O seminário, livro 7: a ética da psicanálise (1959–1960)*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1988.

LACAN, Jacques. *O seminário, livro 10: a angústia (1962–1963)*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2005.

LACAN, Jacques. *O seminário, livro 11: os quatro conceitos fundamentais da psicanálise (1964)*. 2. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2008.

LACAN, Jacques. *O seminário, livro 16: de um Outro a outro (1968–1969)*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2008.

LACAN, Jacques. *O seminário, livro 17: o avesso da psicanálise (1969–1970)*. Rio de Janeiro: Zahar, 1992.

LACAN, Jacques. *O seminário, livro 19: ...ou pior (1971–1972)*. Rio de Janeiro: Zahar, 2012.

LACAN, Jacques. *O seminário, livro 20: mais, ainda (1972–1973)*. 2. ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1985.

LACAN, Jacques. *O seminário, livro 23: o sinthoma (1975–1976)*. Rio de Janeiro: Zahar, 2007.

LACAN, Jacques. *A instância da letra no inconsciente ou a razão desde Freud*. In: _____. *Escritos*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998.

LACAN, Jacques. *Função e campo da fala e da linguagem em psicanálise*. In: _____. *Escritos*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998.

LACAN, Jacques. *O estádio do espelho como formador da função do eu*. In: _____. *Escritos*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998.

LACAN, Jacques. *Resposta ao comentário de Jean Hyppolite sobre a “Verneinung” em Freud*. In: _____. *Escritos*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998.

LACAN, Jacques. *Conferência de Genebra sobre o sintoma (1975)*. In: GARCIA, Joseane. *O fenômeno psicossomático e o objeto a*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2021. p. 105.

LEITÃO, Igor Brum. A construção do estudo de caso em psicanálise. *Contextos Clínicos*, São Leopoldo, v. 11, n. 3, 2018.

MATTUELLA, Luciano. A vergonha e o objeto olhar. *Revista da Associação Psicanalítica de Porto Alegre*, n. 48, 2015.

MENDONÇA, J. Breve história da psicossomática: da pré-história à era romântica. *Revista Médica de Minas Gerais*. 2006. p. 116–22

MELLO FILHO, Júlio de (2010). *Psicossomática Hoje*. Artmed 2ª ed. Porto Alegre.

NASIO, Juan-David. *Meu corpo e suas imagens*. Rio de Janeiro: Zahar, 2009.

NASIO, Juan-David. *O livro da dor e do amor*. Rio de Janeiro: Zahar, 1999.

NICOLAU, R. F. A psicossomática e a escrita do real. *Revista Mal-estar e Subjetividade*, v. 8, n. 4, 2008.

OLIVEIRA, Maeli dos Santos Vareli de; WINTER, Célia Ferreira Carta. Manifestações da histeria na contemporaneidade. *Ágora*, v. 22, n. 3, 2019.

PACHECO, Rodrigo Pinto. O sujeito-lesão e as possibilidades de esvaziamento de gozo na carne. In: DUNKER, Christian et al. *A pele como litoral*. São Paulo: Zagodoni, 2021.

PARABONI, Patricia. *Hipocondria*. Curitiba: Appris, 2019.

QUINET, Antonio. *A estranheza da psicanálise*. Rio de Janeiro: Zahar, 2009.

QUINET, Antonio. Com lángua no corpo. *Stylus*, n. 19, 2009.

QUINET, Antonio. *Os outros em Lacan*. Rio de Janeiro: Zahar, 2012.

QUINET, Antonio. Lángua e sinthoma. *Línguas e Instrumentos Linguísticos*, n. 38, 2016.

RIBEIRO, Maria. As marcas corporais. *Reverso*, Belo Horizonte, v. 32, n. 60, 2010.

SAFATLE, Vladimir; SILVA JUNIOR, Nelson da; DUNKER, Christian. *Patologias do social*. São Paulo: Autêntica, 2018.

SANTOS, Iara Maria Ferreira. *Falas ecológicas: uma discussão sobre a multiplicidade de seus efeitos*. 2015. Dissertação (Mestrado em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2015.

SIMÃO, L.; MOREIRA, S. A histeria de conversão: quando o corpo fala. *Rev. faef*. 15ª ed. SP. Nov, 2010. Disponível em: <http://faef.revista.inf.br/imagens_arquivos/arquivos_destaque/XFli708q7zXtWV2_2013-5-13-15-46-36.pdf>.

SILVA, L. Origens da psicossomática e suas conexões com a medicina na Grécia antiga. *Analytica*. São João del-Rei. v. 5, n. 8, p. 49-79. jan/jun 2016. Disponível em: <<http://pepsic.bvsalud.org/pdf/analytica/v5n8/04.pdf>>.

VENTURA, Ingrid Figueiredo. Uma escrita que brota à flor da pele. *Stylus*, n. 26, 2013.

VOLICH, R. *Psicossomática: de hipócrates à psicanálise*. São Paulo. Casa do Psicólogo. Coleção Clínica Psicanalítica, 2000.